

NOVA EDIÇÃO REVISADA E AMPLIADA

INTRODUÇÃO
À PSICANÁLISE
DE CRIANÇAS
O LUGAR DOS PAIS



Michele Roman Faria

TORO
editora

INTRODUÇÃO À PSICANÁLISE DE CRIANÇAS

O LUGAR DOS PAIS

Michele Roman Faria

TORO
editora

São Paulo
2023

Copyright © 2023 Michele Roman Faria

CRÉDITOS

PROJETO GRÁFICO: Didot Branding & Design

REVISÃO DE TEXTO: Sirlene Barbosa

DIAGRAMAÇÃO: Eva Christie Roman

CAPA: Didot Design

IMPRESSÃO: Romulus Artes Gráficas e Editora

EDITORAÇÃO: Toro Editora

Reimpressão da edição de 2016

Todos os direitos desta edição reservados à

Toro Editora

Telefone: (11) 9 7132-2109

www.toroeditora.com.br

Faria, Michele Roman

Introdução à psicanálise de crianças: o lugar dos pais / Michele Roman Faria. – São Paulo: Toro Editora, 2023.

Reimpressão da ed. de 2016.

Bibliografia.

ISBN 978-85-92779-00-9

1. Freud, Sigmund, 1856-1939 2. Lacan, Jacques, 1901-1981 3. Papel dos Pais
4. Psicanálise 5. Psicanálise infantil I. Título.

19-27670

CDD-155.4

Índices para catálogo sistemático:

1. Crianças : Psicanálise - 155.4

2. Psicanálise Infantil - 155.4

Maria Paula C. Riyuzo – Bibliotecária – CRB – 8/7639

Aos alunos e supervisionandos com quem tenho a alegria de dividir os desafios da clínica psicanalítica com crianças e que, assim, contribuem para manter o desejo de transmissão do qual este livro é fruto.

índice

apresentação desta edição, pela autora **9**

prefácio **13**

introdução **25**

parte 1 o casal parental e a constituição do sujeito **37**

capítulo 1 a mãe, a função materna, o Outro **39**

capítulo 2 a criança, o falo **49**

capítulo 3 o pai, a função paterna, o Nome-do-Pai **59**

capítulo 4 pais e criança: sujeitos, lugares ou funções? **69**

parte 2 a clínica psicanalítica com crianças **79**

capítulo 5 o sintoma e as entrevistas preliminares **81**

capítulo 6 o lugar dos pais na estrutura **87**

conclusões **93**

bibliografia **97**

apresentação desta edição, pela autora

Vinte anos depois de ter defendido dissertação de mestrado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) sobre o lugar dos pais nas psicanálises de crianças, este livro é um retorno ao texto, originalmente publicado em 1998 pela Hacker Editores.

Um retorno que resulta no que poderia ser considerado um novo livro, como poderão constatar os leitores que tiveram acesso à primeira publicação.

Retornar a um texto tantos anos depois, não é tarefa fácil. A bagagem acumulada ao longo destes vinte anos dedicados à prática clínica e à transmissão da psicanálise impôs ao trabalho de revisão uma exigência de rigor que teve como companheira constante a angústia de constatar, a cada termo a ser corrigido, a cada parágrafo a ser reescrito, a dificuldade e as barreiras que envolvem a transmissão da psicanálise.

Essa foi, aliás, a preocupação que marcou do início ao fim o ensino de Lacan, sendo, seus seminários, a expressão contundente do esforço de uma vida dedicada à busca de uma forma de transmissão tão imune quanto possível aos desvios e descaminhos próprios a toda compreensão. Tratando sempre com ironia a crença de que a dificuldade de compreensão da teoria lacaniana teria relação com seu estilo, Lacan insistia em marcar que a verdadeira fonte de tal dificuldade está no próprio objeto do qual os psicanalistas se ocupam, o inconsciente.

Durante anos, a resistência para enfrentar o trabalho de revisão do texto manteve o projeto de republicá-lo a uma certa distância. Ao mesmo

tempo, a pergunta sobre o lugar dos pais continuava marcando presença em toda supervisão clínica, em toda discussão teórica que envolvesse os impasses no manejo da clínica com a criança. As próprias dificuldades oriundas da experiência clínica seguiam demandando respostas para a pergunta sobre o lugar dos pais nas análises de seus filhos – e mantinham, portanto, no horizonte, o projeto de retornar ao livro.

Somava-se a tudo isso a escassez de publicações sobre o assunto, que parecia indicar certa resistência suscitada por um tema relegado a segundo plano e tratado sem a merecida relevância, com alguns raros psicanalistas se ocupando dos problemas da transferência dos pais. Ainda que minha experiência de escutar psicanalistas em suas práticas clínicas insistisse em mostrar os efeitos do manejo da transferência dos pais na clínica psicanalítica com crianças, a tendência de tratar as interferências dos pais – aquelas que resultam em faltas, atrasos, interrupções – como resistência parecia manter os próprios psicanalistas na posição que Lacan tentou denunciar ao afirmar que a resistência é do analista.

As dificuldades da clínica psicanalítica com crianças seguiam exigindo respostas para a pergunta sobre o lugar dos pais nas análises de seus filhos e continuavam mantendo vivas as mesmas perguntas que eu levantara no início de minha prática clínica e que haviam conduzido à pesquisa do mestrado.

Perguntas que tiveram como fonte de inspiração, ainda na graduação do curso de psicologia da USP, a ousadia da professora Jussara Falek Brauer, que propunha escutar as mães como uma estratégia de manejo para os casos considerados graves, confiando no inexperiente aluno de graduação para conduzi-los – o que era ainda uma ousadia à parte. O desafio do manejo destes casos marcaria minha prática com crianças com a aposta de que oferecer uma escuta aos pais era uma necessidade, quase um imperativo, desta clínica.

Foi certamente o encantamento por uma posição ética diante destes casos que me capturou e deu suporte a uma longa relação na qual Jussara não foi apenas supervisora, mas orientadora do mestrado e do doutorado, além de coordenadora de um curso de aprimoramento montado para discutir essas questões e do qual fiz parte como docente, em meus primeiros passos na transmissão da psicanálise.

Do curso, resultou o livro *A criança no discurso do Outro* (Iluminuras,

1994) com artigos que discutiam os casos clínicos e os desafios de seu manejo, fruto do trabalho de Jussara e de sua aposta clínica. Nele, o artigo "Análise de quem?" daria origem à pesquisa de mestrado, publicado sob o título *Introdução à psicanálise de crianças: o lugar dos pais*, em 1998.

Nestes últimos anos, cada demanda de indicação de leitura sobre o tema e cada pedido de exemplar do livro já esgotado renovava a motivação para uma nova publicação.

Superadas as resistências que fizeram adiar por tanto tempo o projeto de revisá-lo, um dos maiores prazeres de voltar ao texto foi constatar, 20 anos depois, que a mesma posição ética assumida na ocasião da pesquisa continua norteando minha clínica e minha escuta dos pais. É portanto da alegria de reencontrar o fio de minha história como psicanalista de crianças que resulta esta nova publicação, pela Toro Editora.

Os capítulos foram reescritos, na busca de maior clareza e precisão na transmissão dos conceitos, mas a estrutura do texto permanece a mesma da edição original.

A estratégia adotada para abordar os problemas que envolvem a prática clínica com crianças e o lugar dos pais nesta prática segue sendo a de mostrar que a presença dos pais está marcada desde o início nos tratamentos das crianças e que, portanto, o manejo dessa presença se impõe, esteja o psicanalista advertido ou não de sua necessidade.

O lugar oferecido aos pais nas análises de crianças, mais que mera formalidade exigida pela técnica, é revelador da forma como o psicanalista compreende o que é uma criança, sua inserção no triângulo pai-mãe-criança e os efeitos que se espera de seu tratamento.

A proposta do livro segue sendo a de trazer contribuições para buscar uma intervenção que esteja de acordo com a ética sustentada por Lacan ao longo de seu ensino, ainda que nenhuma palavra sobre o manejo clínico da presença dos pais nas análises das crianças tenha sido dada por Lacan. É esta, aliás, a árdua tarefa que se impõe ao psicanalista em sua prática clínica com pais e crianças: encontrar o fio de um manejo que se pretenda rigorosamente lacaniano, sem que o próprio Lacan tenha deixado mais do que algumas pistas sobre o caminho a seguir.

prefácio, por Jussara Falek Brauer

Para a psicanálise de inspiração lacaniana, o discurso é o seu campo.

Mas em que sentido devemos tomar aqui o discurso? Lacan, na introdução do texto "A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud", diz que sua contribuição fica a meio caminho entre o escrito e a fala.

Como tomar essa contribuição que se inscreve entre o escrito e a fala? Há que se distinguir, nos ensina o autor, o que há para ler naquilo que se ouve. O que é da ordem do inconsciente é, antes de mais nada, aquilo que se lê. Muito se enriquece, essa contribuição, quando recorta, na teorização feita por Freud sobre a transferência, que se trata de ler aí onde algo silencia, já que em se tratando de transferência, algo silencia.

O que é para leitura para Lacan, o que se lê em Lacan? Alduizio Moreira de Souza nos esclarece:

[o que se lê na obra de Lacan é] Jogo posicional, onde uma estrutura em ato se compõe. Pura estruturalidade lógica, determinada pelas posições de significante [...] O sujeito é produto de um jogo posicional de significantes. Se o sujeito aparece então como efeito de uma colocação em ato de dois significantes (S1 e S2), ele é um produto de um corte simbólico para sustentar uma emergência no Real, imaginando-a [...].¹

A argumentação de que o campo do inconsciente é o campo da linguagem começa a ser desenvolvida nos anos 1950. Trata-se de uma argumentação importante porque com ela Lacan estabelece os fundamentos da prática analítica, ele coloca em nossas mãos a nossa

¹ SOUZA, A. M. *Uma leitura introdutória à Lacan (exegese de um estilo)*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985, p.17.

ferramenta de trabalho. Mas é muito importante frisar que não se trata, em nenhum momento, de reduzir a psicanálise à linguística, e menos ainda de propor que nos devamos ater exclusivamente a uma análise do discurso.

Aquilo de que se trata é de situar a psicanálise no campo das ciências do homem em contraposição ao campo das ciências exatas.

Lacan procura, nesse momento, resgatar a contribuição de Freud, fazendo à sua obra aquilo que se poderia chamar de um "retorno inventivo".

Ele relê Freud a partir dos avanços de sua época no que diz respeito às ciências humanas. Nesse sentido, Lacan recia a psicanálise, mas ele sempre reitera que se mantém fiel à invenção freudiana.

Nesse momento, é preocupação de Lacan apontar os desvios que a psicanálise da época teria feito em relação à obra de Freud. O autor argumenta com base naquilo que ele propõe como sendo os fundamentos da disciplina psicanalítica residindo aí sua invenção ao retornar a Freud.

Lacan preocupa-se em diferenciar o campo da psicanálise daquele da psicologia e apóia, na linguística estrutural, sua formulação.

Ele afirma que:

Uma psicanálise chega normalmente a seu termo sem nos informar senão pouca coisa do que nosso paciente tem de próprio em sua sensibilidade aos golpes e às cores, da prontidão de suas respostas ou dos pontos fracos de sua carne, de seu poder de reter ou de inventar, e mesmo da vivacidade de seus gostos.²

E contrapõe:

Quanto à Psicopatologia da vida quotidiana, [...], é claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido, e mesmo bem graciosamente elaborado, e que no lapso é a mordada que gira sobre a fala, e justo com o quadrante que é preciso para que um bom entendedor aí encontre sua meia-palavra [...].

Pois se para admitir um sintoma na psicopatologia psicanalítica, quer seja neurótico ou não, Freud exige o mínimo de sob redeterminação que constitui um duplo sentido, símbolo de um conflito defunto mais além de sua função num conflito presente *não menos simbólico*, se ele nos ensinou a seguir no texto das associações livres a ramificação ascendente dessa linhagem simbólica, para aí referenciar nos pontos onde as formas verbais se inter cruzam os nós de sua estrutura — já está de todo claro que o sintoma se resolve inteiramente numa análise de linguagem, porque ele próprio é estruturado como uma linguagem, que ele é linguagem cuja fala deve ser liberada.³

² LACAN, J. "Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise". In: *Escritos*. São Paulo: Perspectiva, 1978, p.130-131.

³ Idem, p.133.

Nota-se bem que aquilo que o autor aponta está mais do lado da técnica e menos do lado do fenômeno, se podemos dizer assim. Não se trata, pois, de restringir a visada do analista ao discurso do analisante apenas, mas de orientar a intervenção do analista. Note-se ainda que ele toma o cuidado de falar do sintoma, *seja ele neurótico ou não*. Isso quer dizer que estão aí incluídas coisas como a passagem ao ato por exemplo, ou lesões no corpo de origem psicossomática, etc. Temos aqui a leitura que se vai fazer disso tudo, decorrendo dessa leitura o tipo de intervenção que se vai fazer, ou ainda, sendo a intervenção, ela mesma, uma leitura.

A psicanálise privilegia o significante sob a condição de que ele tenha valor de escritura do caso singular, sob a condição de que escreva a história singular do sujeito em análise.

Lacan dialoga com a linguística, mas em nenhum momento sua visada é o discurso tomado enquanto objeto de estudo. Os avanços da linguística, ele os toma como ferramentas de trabalho. Seu objeto, no que tange à psicanálise, é o objeto pulsional, conceito que ele diferencia da noção de instinto, valendo-se ainda uma vez do discurso tomado como argumento. Diz o autor:

E daí insistimos em promover que, fundado ou não na observação biológica, o instinto entre os modos de conhecimento que a natureza exige do vivente para que ele satisfaça as suas necessidades, se define como esse conhecimento que se admira por não poder ser um saber. Mas outra coisa é aquilo de que se trata em Freud, que é um saber, mas um saber que não comporta o menor conhecimento, por estar inscrito num discurso, do qual, assim como o escravo-mensageiro do uso antigo, o sujeito que traz sob sua cabeleira o codicilo que o condena à morte, não conhece nem o sentido nem o texto, nem em que língua está escrito, nem mesmo que lho tatuaram sobre seu couro raspado enquanto dormia.⁴

Enuncia assim, de forma poética, o inconsciente, matéria com a qual trabalha a psicanálise. O inconsciente e não o comportamento e nem mesmo o instinto.

Separa-se assim por um lado da psicologia, e por outro de todo fundamento biológico, apoiando-se para isso no discurso.

A obra de Lacan é a elucidação epistemológica da psicanálise, objetivo que ele perseguirá até o fim, apoiando-se para tanto em outros saberes ainda, tais como a lógica, a topologia, etc.

⁴ LACAN, J. "Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano". In: *Escritos*. São Paulo: Perspectiva, 1978, p.286.

As difíceis e intrincadas ideias desse autor puderam ser ditas de outra forma pelo poeta Jorge Luís Borges, ao elucidar, no conto "A trama", que:

Para que seu horror seja perfeito, César, acossado ao pé de uma estátua pelos impacientes punhais de seus amigos, descobre entre os rostos e as armas o de Marco Júnio Bruto, seu protegido, quicá seu filho, e já não se defende e exclama: *Tu também, meu filho!* Shakespeare e Quevedo recolhem o grito patético. Ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias; dezenove séculos depois, no Sul da província de Buenos Aires, um gaúcho é agredido por outros gaúchos e, ao cair, reconhece um seu afilhado e lhe diz com mansa recriminação e lenta surpresa (estas palavras devem ser ouvidas, não lidas): *Pero che! Matam-no e ele não sabe que morre para que uma cena se repita.*⁵

Há que se distinguir o que há para ler naquilo que se fala, isso parece não ter escapado a Borges. O inconsciente situa-se entre o escrito e a fala, esta a especificidade do recorte de Lacan. O que é da ordem do inconsciente é antes de mais nada aquilo que se lê, aquilo que permite a escritura da história subjetiva, e que é da ordem da repetição, repetição de algo que se elucida em uma outra cena – a do inconsciente.

O equívoco é a via pela qual o sujeito existente pode ex-sistir ao enunciado, ao dito, sendo, no ato, sujeito do Inconsciente. As linhas de composição da estrutura, SINTHOME as chama Lacan, é a lei paterna, operando os significantes do Nome-do-pai. Espiritualidade em ato para que, no deserto da existência concreta, possa brotar uma ex-sistência paradoxal, que é equívoca, mas que coloca o sujeito diante da sua verdade, pela ética que daí se deduz [...].⁶

Essa leitura particular que é a analítica permite que se quebre a repetição, que não seja preciso realizar um destino. Ao invés disso, propicia ao sujeito um ensejo de se posicionar ante os significantes que o marcaram, em uma nova temporalidade.

Paul Ricoeur desenvolve a ideia e nos permite situá-la melhor. Para ele, o que recebemos da psicanálise como dádiva foi a possibilidade de esquecer. A história nos pesa, diz ele, ela se repete em nossos atos inconscientes, em nossos sonhos, em nossos lapsos, naquilo que esquecemos. A história se presentifica naquilo que esquecemos. Ele diz: "O esquecimento é condição da memória. O esquecimento é a presença mesmo de uma ausência".⁷

5 BORGES, J. L. A trama. In: *O fazedor*.

6 SOUZA, A. M. *op. cit.*, p.16.

7 Em debate sobre "Memória e Esquecimento", Paris, 1997.

A psicanálise vai trabalhar com essa matéria, o esquecido, para que seja reconstruído, e possa ser novamente esquecido depois. Após a análise, nos é dado esquecer a história.

Cito agora um fragmento de outro conto de Borges denominado "Mutações", que me permite concluir:

Cruz, laço, flecha, velhos utensílios do homem, hoje rebaixados ou elevados a símbolos; não sei por que me maravilham, quando não há na Terra uma única coisa que o esquecimento não apague ou que a memória não altere e quando ninguém sabe em que imagens o porvir o traduzirá.⁸

Discurso e linguagem em Lacan, isto é, uma *dizimensão*, em um domínio no qual a lei é a da repetição.

No *Seminário 20*, já no ano de 1975, Lacan liga essa *dizimensão* ao gozo, ao dizer:

Não é isso - aí está o grito por onde se distingue o gozo obtido do gozo esperado. É onde se especifica o que se pode dizer na linguagem [...]. A estrutura [...] não demonstra outra coisa senão que ela é do mesmo texto que o gozo, na medida em que ao marcar de qual distância ela falta, aquela de que se trataria se fosse isso, ela suporta com isso uma outra [...] inconsciente.⁹

Ao tomar a criança e seu sintoma a partir da estrutura familiar, onde pais e criança contam, antes de mais nada, como posições que se assumem no interior dessa estrutura, quebra-se com uma ordem de leitura da criança, aquela que a toma na sua positividade, enquanto ser em desenvolvimento, explorando esse momento inicial do trabalho, a partir dos fundamentos acima enunciados.

Entendo que o trabalho de ordenar esse campo de intervenção que se abre a partir das formulações feitas por Freud e Lacan seja da maior importância, por permitir contornar dificuldades que a estrita leitura da criança como ser em desenvolvimento nos deixou.

Se a ideia de desenvolvimento foi fecunda a ponto de permitir a criação de um novo campo de pesquisa científica, aquele voltado ao estudo da criança, mais tarde verificou-se que a mesma ideia, quando colocada de forma absoluta, pode ser capaz de produzir erro de diagnóstico e de consequente encaminhamento das questões apresentadas por uma criança.

8 Idem.

9 BORGES, J. L. Mutações. In: *O fazedor*, p.34. Difel, 1984.

Se os sintomas apresentados pelas crianças podem ser descritos fenomenologicamente como "distúrbios no desenvolvimento", muitas vezes há que se ir mais além para montar uma estratégia clínica de intervenção sobre estes mesmos sintomas.

Assim, se conhecer o curso normal de desenvolvimento de uma criança pode ser valioso, no sentido de permitir detectar qualquer tipo de problema, quando se trata de um distúrbio que tenha o estatuto de um sintoma na aceção analítica do termo, aquele que é sobredeterminado, conforme descrito acima, um novo problema se coloca.

Poderíamos então perguntar qual o estatuto dessa ideia de desenvolvimento no campo da psicanálise, ou ainda, tomando-se em conta o fato inegável do desenvolvimento do corpo biológico no caso da criança: que limites esse desenvolvimento impõe ao trabalho do psicanalista? Enfim, que articulação teórica é possível ou se impõe fazer no caso da criança?

Se retomamos a leitura dos textos de Freud, veremos que, para ele, a análise é concebida como sendo um trabalho que se realiza sobre a neurose infantil.

É fundamental, no entanto, que se estabeleça uma diferença entre neurose infantil e neurose na infância.

Vejamos então o que diz o autor, o que ele escreve a esse respeito e a que título utiliza este termo *neurose infantil*.

Freud vai empregar o termo *neurose infantil*, por exemplo, no título de seu artigo sobre o historial clínico do Homem dos lobos.

Citando o autor¹⁰:

Trata-se de um homem jovem que adoeceu aos dezoito anos, imediatamente depois de uma infecção blenorragica, e que ao ser submetido, vários anos depois, ao tratamento psicanalítico, se mostrava totalmente incapacitado. Durante os dez anos anteriores à sua enfermidade, sua vida havia sido aproximadamente normal e havia levado a cabo seus estudos de segundo ciclo sem grandes transtornos. Mas sua infância havia sido dominada por uma grave perturbação neurótica que se iniciou nele, pouco antes de completar os quatro anos, como uma histeria de angústia (zoofobia), se transformou logo em uma neurose obsessiva de conteúdo religioso e alcançou, com suas ramificações, até os dez anos do sujeito.

No presente ensaio ocupar-nos-emos tão só desta *neurose infantil*. Apesar de haver sido expressamente autorizados pelo paciente, recusamo-nos a publicar o historial completo de sua enfermidade, seu tratamento e sua cura, considerando-o tecnicamente irrealizável e inadmissível desde o ponto de vista social.

Com isso, desaparece também toda possibilidade de mostrar a conexão de sua enfermidade infantil com sua posterior doença definitiva, sobre a qual podemos só indicar que o sujeito passou, por causa dela, anos inteiros em sanatórios alemães, nos quais se qualificou seu estado de *lucura maniaco-depressiva*. Este diagnóstico teria sido exato aplicado ao pai do paciente, cuja vida, intensamente ativa, foi perturbada por repetidos acessos de grave depressão. Mas no filho não me foi possível observar, em vários anos de tratamento, mudança alguma de estado de ânimo que por sua intensidade ou as condições de sua aparição pudesse justificá-lo.

Em minha opinião, este caso, como muitos outros diversamente diagnosticados pela psiquiatria clínica, deve ser considerado como um estado consecutivo de uma neurose obsessiva que chegou espontaneamente a uma cura incompleta. Minha exposição referir-se-á, pois, tão somente a uma neurose infantil analisada não durante seu curso, mas quinze anos depois, circunstância que tem suas vantagens e seus inconvenientes. A análise levada a cabo no sujeito neurótico infantil parecerá, desde logo, mais digna de confiança, mas não pode ser muito rica em conteúdo. Temos que emprestar à criança demasiadas palavras e demasiados pensamentos, apesar do que não conseguiremos talvez que a consciência penetre até os estados psíquicos mais profundos. A análise de uma enfermidade infantil por meio da recordação que dela conserva o sujeito adulto e já maduro intelectualmente não apresenta tais limitações, mas teremos de levar em conta a deformação e a retificação que o próprio passado experimenta ao ser contemplado desde anos posteriores. O primeiro caso proporciona talvez resultados mais convenientes, mas o segundo é muito mais instrutivo.

Freud¹¹ tratou predominantemente adultos. A prática da psicanálise da criança só foi instituída após os trabalhos de Melanie Klein – a pioneira em tomar crianças como pacientes.¹²

Freud deixa-nos, no entanto, a partir da leitura do texto acima, algumas questões sobre o assunto.

Em primeiro lugar, afirma que sua escolha pela neurose infantil do Homem dos lobos é uma escolha estratégica, que tange aos aspectos que ele vai privilegiar no decurso dessa análise de um adulto. Em segundo lugar, coloca algumas dificuldades no caso do trabalho psicanalítico com crianças. O importante a frisar aqui é também o fato de Freud problematizar o diagnóstico psiquiátrico atribuído a seu paciente, à luz dos resultados obtidos por ele, a partir do trabalho analítico conduzido sobre a neurose infantil.

11 FREUD, S. (1909), "História de uma neurose infantil".

12 A este respeito é interessante que se leia Jacques Lacan, por Elizabeth Roudinesco. Neste livro, a autora relata essa parte da história da psicanálise de ou com crianças, mais exatamente, no capítulo 4 intitulado de "Marienbad".

10 LACAN, J. *Mais, ainda*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1982, p.152.

Autor saído do campo da medicina, Freud pende em sua obra ora para o biológico, campo de onde parte, ora para o estrutural, campo novo onde irá se introduzir. Concebe o aparelho psíquico em desenvolvimento, e fala em fases: oral, anal etc. Mas é para depois romper com o biológico que vai construindo assim sua argumentação, chegando a forjar o termo pulsão, conceitualmente diferenciado de impulso ou instinto, termos cuja referência ao corpo biológico faz com que sejam inconvenientes à representação do conceito novo que o autor introduz.

Na língua alemã, Freud dispunha dos termos *Trieb* e *Instinkt* que lhe permitiram a distinção que vai introduzir no *Três ensaios sobre a teoria da sexualidade*, datado de 1905. Foi nessa obra que, baseando-se no estudo das perversões e das modalidades da sexualidade infantil, chegou a propor o termo pulsão parcial que se estabelece por uma ligação ao mesmo tempo às fontes somáticas parciais diversas em oposição à genital, e às vicissitudes da história do indivíduo, sendo que, segundo o autor, a primazia das pulsões parciais, desenvolvida no texto "Três ensaios sobre uma teoria da sexualidade", caminha na contramão do desenvolvimento, uma vez opera durante o período em que este desenvolvimento biológico sofre uma latência. A releitura do texto pode ser muito ilustrativa a partir desse ponto.

No texto de 1905, Freud irá discorrer sobre um período ao qual denominou *período de latência sexual*, o qual, ao invés de indicar um desenvolvimento, conduz a uma parada no desenvolvimento, a uma latência. O autor afirma: "Durante este período de latência total ou simplesmente parcial, constituem-se os poderes anímicos que depois se opõem ao instinto sexual e o canalizam, traçando-lhe o curso à maneira de dique."¹³

Ele assegura, assim, que é a parada no desenvolvimento que ocorre no período de latência aquilo que vai determinar os caminhos da sexualidade adulta, *traçando-lhe o curso à maneira de dique*.

É assim que o autor falará na criança como sendo um "perverso polimorfo", ou seja, que por razões ligadas ao seu desenvolvimento corporal, ou à latência desse desenvolvimento, a criança, que para o autor tem uma sexualidade, a tem estruturada sob a perspectiva das pulsões parciais, ou seja, sob a perspectiva da estrutura perversa.

Portanto, se a pulsão não é o instinto, e isso permite ao autor falar

em uma sexualidade infantil que não é genital, por outro lado, no caso da criança o fato do desenvolvimento do corpo (e adicionaríamos a isso o fato do lugar da criança na estrutura social e familiar) faz pensar que a estrutura psíquica da criança seria por excelência a estrutura perversa.

Abrindo o *Seminário 13*, "O objeto da psicanálise", Lacan (1965-66) nos diz que a relação da mãe com a criança é uma relação perverso polimorfa, fazendo, com isso, repousar nessa relação o fundamento da perversão infantil.

Em Lacan, a ênfase será posta sobre a pulsão, e o autor pensará segundo o valor do objeto pulsional (objeto *a*) dentro da estrutura.

A ideia de desenvolvimento caindo, ao dar lugar a uma abordagem estrutural do sujeito, terá então servido à psicanálise para alimentar seu movimento dialético, sendo depois superada, para dar lugar a uma concepção estrutural.

Assim, se do ponto de vista do imaginário social, a criança se constitui, por assim dizer, um *consumidor* da psicanálise, resta ainda saber se para atender a esse tipo de demanda de trabalho, a psicanálise precisa construir um corpo teórico diferenciado que dê conta desse lugar diferenciado que a criança ocupa, de sua sexualidade infantil enquanto "perverso polimorfo".

Retornemos então sobre a questão, agora a partir do registro do simbólico.

Trata-se, aqui, da estrutura. Sob a perspectiva aberta pela psicanálise, a criança é concebida como posição que se ocupa no interior da estrutura familiar, e não mais como uma etapa no desenvolvimento.

Encontraremos em Lacan a perspectiva para trabalhar essa problemática.

No texto "Duas notas sobre a criança", ele dirá:

Na concepção elaborada por Lacan, o sintoma da criança está em posição de responder ao que há de sintomático na estrutura familiar.

O sintoma, e este é o fato fundamental da experiência analítica, se define neste contexto como representante da verdade.

O sintoma pode representar a verdade do casal. Este é o caso mais complexo, mas também o mais aberto a nossas intervenções.

A articulação se reduz em muito quando o sintoma que chega a dominar compete à subjetividade da mãe. Desta vez, a criança está involucrada diretamente como correlativo de um fantasma.¹⁴

13 FREUD, S. (1905). "Três ensaios sobre a sexualidade", p.322.

14 LACAN, J. "Duas notas sobre a criança". In: *Intervenciones y textos*. Avellaneda: Manantial,

Se seguirmos então as indicações do autor, veremos que em primeiro lugar é possível pensar a análise de crianças tendo como referência aquilo que já se encontra teorizado no campo da psicanálise, utilizando conceitos como sintoma ou fantasma, não havendo, portanto, necessidade de pensar em uma psicanálise *de crianças*, mas em psicanálise simplesmente.

Se utilizarmos os fundamentos da psicanálise, teremos ainda, segundo escreve Lacan no texto supracitado, que há aí especificidades.

Quando se trata de sintomas apresentados por uma criança, ele diz que temos aí implicados os pais dessa criança. Essa implicação pode ser de dois tipos ainda, segundo o mesmo autor: ou bem o casal estará implicado aí em termos de sua verdade ou então será a mãe a implicada, e o sintoma da criança será o correlativo do fantasma materno.

Isso ajuda a pensar a clínica infantil e suas especificidades, abrindo um novo campo.

É comum, quando se trabalha com crianças, presenciar-se a irrupção dos pais no tratamento dos filhos.

Se na análise do adulto, podemos nos ater a lidar somente com as fantasias de nossos analisantes, circunscrever o âmbito de nosso trabalho à associação livre, quando se trata da criança, já não podemos nos dar a esse luxo.

A realidade nos aborda todo o tempo. É a escola a pedir laudos e orientações, o médico que recorre a nós, a mãe que nos procura com a insistente pergunta: "o que é que meu filho tem?".

Tal pergunta deve ser lida como emergência no real de um significante materno ou do casal de pais. E se a tomamos como emergência no real é porque não a tomamos a partir da realidade, mas como passagem ao ato, algo passível de uma leitura no sentido em que falávamos acima.

Uma tal leitura determina a conduta de tomar tal pergunta analiticamente, oferecendo também aos pais, ou à mãe, uma escuta analítica com a finalidade de aí operar, favorecendo o engaste transferencial que permitirá, passando ao nível do discurso, cessar a atuação e iniciar o trabalho analítico.¹⁵

Assim, quando se trata desse tipo de trabalho, que envolve crianças, uma opção se abre: de trabalhar esse campo onde encontramos ligados criança e pais na forma de uma colagem significativa. Essa ligação produz

na mãe ou no casal um sofrimento que, por ser dados por procuração à criança, torna-lhe difícil o acesso, torna seu reconhecimento árduo, enquanto sofrimento destes pais ou desta mãe.

É na singularidade de cada caso que iremos pesquisar o sintoma apresentado pela criança, tendo em nosso horizonte de possibilidades, que se trate de uma questão do casal ou mesmo da mãe. Trabalhada a perversão polimorfa dessa relação, nossa criança estará habilitada a optar por crescer, entrar em latência, construir um sintoma que lhe possibilite a entrada em análise, ou ainda optar por contentar-se do Outro, configurando-se como psicótica.

Trabalhar assim, na estrutura familiar, foi uma possibilidade sugerida pela teorização lacaniana, que ainda no mesmo *Nota sobre a criança*, conclui:

A função de resíduo sustentada (e ao mesmo tempo mantida) pela família conjugal na evolução das sociedades, realça o irredutível de uma transmissão – que é de uma outra ordem que a da vida conforme as satisfações das necessidades – mas que é de uma constituição subjetiva, implicando a relação a um desejo que não seja anônimo. É de acordo com uma tal exigência que se julgam as funções da mãe e do pai. Da mãe: na medida em que seus cuidados levam a marca de um interesse particularizado, ainda que pela via de suas próprias faltas. Do pai: na medida em que seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei do desejo.¹⁶

As consequências de uma tal postura são trabalhadas no texto que segue, onde Michele Roman Faria explora-lhe os meandros, buscando uma ordenação do campo, uma maneira mais precisa de definição, e exemplificando como a clínica vai pavimentando assim um caminho já aberto por Freud e retomado por Lacan, de tal forma que penso possa ser de grande utilidade para pensar uma clínica com crianças que vise ao estrutural, à superação dos impasses que uma visão da criança apenas como ser em desenvolvimento pode encontrar, sem perder de vista o rigor da técnica psicanalítica, mas permitindo-se desenvolver uma reflexão a partir de uma fenomenologia específica à clínica do infantil.

1991. p.55.

15 A esse respeito, ver Jean Allouch, no livro *Letra a letra*, no capítulo sobre a transferência.

16 LACAN, J. *op. cit.*, p.55.

introdução

A psicanálise de crianças tem início em 1909, com o primeiro caso de análise de criança publicado por Freud, o caso do pequeno Hans.

Através do relato do tratamento da fobia de uma criança de cinco anos, Freud mostrava que a técnica psicanalítica, aplicada até então somente em pacientes adultos, poderia também ser utilizada para tratar as neuroses das crianças. Nessa época, dedicava atenção especial à sexualidade infantil e à hipótese de que as neuroses teriam suas raízes na infância, e é esse interesse que o levará a acompanhar o caso do menino que desenvolve uma fobia de cavalos.

Mais tarde, em *História de uma neurose infantil* (1918), Freud afirmará que as análises de neuroses de crianças teriam um interesse particular, pois por meio delas seria possível obter dados que poderiam auxiliar na compreensão das neuroses de adultos. Afirmará também que as neuroses tratadas ainda na infância estariam livres das distorções e reelaborações às quais o material trazido por adultos está sujeito e que, por essa razão, trariam resultados mais convincentes.

Ainda assim, curiosamente, Freud não considera a análise de crianças tarefa fácil. Nesse mesmo texto, chama a atenção para uma "dificuldade de perceber o acesso à vida mental de uma criança, o que a torna tarefa particularmente difícil para o médico".¹

Ora, se a criança fornece ao analista um material menos distorcido que o adulto, se sua análise é capaz de facilitar o entendimento das neuroses dos adultos, se seus resultados são mais convincentes, qual seria a particular dificuldade a ser enfrentada pelo psicanalista de crianças?

1 FREUD, S. (1918), p.21.

No caso do pequeno Hans, Freud considera que seu método não teria o mesmo resultado se não fosse um elemento facilitador: o tratamento de Hans foi conduzido não por ele, mas pelo pai do menino. Segundo ele, ninguém mais poderia ter persuadido a criança a fazer as declarações que fez a não ser o pai, e o método psicanalítico só pôde ser aplicado nesse caso porque "a autoridade de um pai e a de um médico se uniam em uma só pessoa, e porque nela se combinavam o carinho afetivo com o interesse científico".²

Essa condição de aplicação do método psicanalítico sugerida por Freud merece reflexão. Afinal, se a presença dos pais se impõe ao psicanalista de crianças, as questões sobre seu manejo acompanham as análises de crianças desde seus primórdios.

A ousadia clínica de Freud, que autoriza o pai a conduzir a análise do próprio filho, deu lugar a estratégias de manejo que incluíram o brinquedo e o desenho no *setting* analítico. As dificuldades técnicas foram contornadas e a psicanálise passou a ser aplicada no tratamento de crianças com o mesmo rigor e a mesma eficácia que nos tratamentos de adultos.

Entretanto, o lugar dos pais não deixou de ser uma questão para os psicanalistas de crianças. Se o próprio Freud a imortalizou ao propor que Hans fosse analisado pelo pai é, entretanto, a clínica que a mantém viva, porque nela a presença dos pais se impõe desde o início.

Mannoni observa, sobre a presença dos pais nas análises dos filhos, que "a questão de saber se eles têm ou não que aparecer na cena analítica é um falso problema, pois aconteça o que acontecer, eles sempre irromperão".³

Que os pais estão, de uma maneira ou de outra, presentes nas análises de crianças, é um fato. São os pais que, em um primeiro momento, se queixam, são eles que marcam horários e pagam pelo tratamento. A condição de dependência da criança torna imprescindível sua presença durante todo o tratamento e, inclusive, é deles que depende sua continuidade. A pergunta sobre o lugar dos pais se impõe, portanto, desde a clínica.

No entanto, a prática clínica dos psicanalistas não oferece um padrão de manejo da presença dos pais. O modo como psicanalistas de crianças

incluem os pais na cena analítica, as formas escutar e compreender seu discurso e as razões para incluí-los ou excluí-los do *setting* são bastante diversas e têm, inclusive, consequências na condução e no manejo do tratamento da criança.

Winnicott, por exemplo, em seu livro *Da pediatria à psicanálise*, afirma:

Os pais que vêm à consulta se sentem culpados com relação ao sintoma ou à doença da criança e à maneira como médico se comporta determina se eles irão calmamente retomar a responsabilidade que podem perfeitamente assumir ou ansiosamente delegá-la ao médico ou à clínica.⁴

Partindo dessa premissa, Winnicott propõe um manejo clínico muito semelhante ao de Freud, sugerindo que nos casos em que a criança está em um "bom lar" e quando há "habilidade dos pais de curar a criança", que os próprios pais conduzam o tratamento, sob sua orientação. As sessões com a criança não estariam excluídas, mas ele entende que "existem muitos casos nos quais as sessões de psicoterapia podem ser omitidas e toda a terapia pode ser feita pelo lar".⁵

A estratégia é semelhante à de Freud: os pais conduzem o tratamento sob a orientação do psicanalista. Mas Winnicott não propõe esse manejo para todos os casos, é uma estratégia utilizada nos casos em que não há necessidade da "análise-padrão".

Para alguns analistas, a inclusão dos pais chega a ser considerada um facilitador da análise da criança. Anna Freud sustenta essa posição de forma radical, propondo que as crianças não poderiam ser analisadas sem que os pais também o fossem.

Melanie Klein foi a primeira psicanalista de crianças a criticar o manejo que inclui os pais, especialmente quando ele visa efeitos sobre a criança. Para ela, o tratamento psicanalítico deveria dar ênfase às fantasias da criança e não à realidade do ambiente que a cerca. Em seu *Simpósio sobre a análise infantil* (1927), ela afirma:

Em resposta, eu diria que devemos discriminar muito claramente entre as atitudes conscientes e inconscientes dos próprios pais e que descobri repetidas vezes que as atitudes inconscientes não estão, de modo algum, garantidas pelas condições pretendidas por Anna Freud. Os pais podem estar, teoricamente, bem convencidos da necessidade da análise e podem desejar conscientemente ajudar-nos

2 Idem, 1909, p.15.

3 MANNONI, M. 1985, p.63.

4 WINNICOTT, D. W. 1988, p.166.

5 Idem, p.230.

com todas as suas forças, mas, sem embargo, por razões inconscientes podem criar obstáculos ao nosso trabalho, a todo momento.⁶

A autora lembra que as interferências por parte dos pais nos atendimentos de crianças são comuns e não acredita que seu encaminhamento para uma análise pessoal tenha efeito direto sobre tais interferências. Ela sugere, ao contrário, que a análise da criança deve ser feita apesar e contra tais interferências, e sua estratégia consiste em excluí-los, na medida do possível, do tratamento.

A mesma estratégia é adotada por Arminda Aberastury que propõe, para a entrevista com os pais:

É necessário que essa entrevista seja dirigida e limitada de acordo com um plano pré-estabelecido, porque, não sendo assim, os pais, embora conscientemente venham falar do filho, têm a tendência de escapar do tema, fazendo confidências de suas próprias vidas. A entrevista tem o objetivo de que nos falem sobre a criança e da relação com ela; não devemos abandonar esse critério durante todo o tratamento.⁷

Aberastury entende que os pais atrapalham, considera suas confidências inadequadas, e sugere que o psicanalista deve fazê-los falar daquilo que realmente interessa, ou seja, da criança.

Já Maud Mannoni, ao contrário, não apenas se ocupa do que os pais têm a dizer, como utiliza seu discurso como um elemento central da própria análise da criança. Para ela, o tratamento de uma criança consiste em "procurar o enigma do sintoma por uma atenção voltada para o conjunto do discurso da criança e dos pais".⁸

Mannoni entende que "o discurso que se processa engloba os pais, a criança, o analista: é um discurso coletivo que se constitui em torno da criança".⁹ Por isso, sugere que o psicanalista se interrogue sobre o lugar da palavra da mãe no mundo fantasmático da criança, assim como sobre o lugar do pai na palavra da mãe. Conforme a autora, haveria um discurso comum que une pais e criança sintomaticamente, estando as causas do sintoma da criança nos efeitos tanto do que é dito como do que é silenciado a ela. A presença dos pais adquire papel central no próprio trabalho com a criança, porque seu discurso passa a ser utilizado no esclarecimento do sintoma da criança.

6 KLEIN, M. 1982, p.228.

7 ABERASTURY, A. 1992, p.82.

8 MANNONI, M. 1987, p.194.

9 Idem, p.9.

Para Mannoni, não se trata da análise dos pais, mas de recolocar sua mensagem no nível do tratamento da criança. A autora faz, inclusive, uma série de objeções a qualquer outra possibilidade de intervenção com os pais. Obrigá-los a uma análise pessoal é, segundo ela, inútil, na medida em que seu sintoma se apresenta alienado no sintoma da criança. A cura da criança dependeria, segundo Mannoni, da compreensão do lugar que a criança ocupa no fantasma dos pais.

A proposta de Françoise Dolto é semelhante à de Mannoni. Dolto também ressalta a importância do que dizem os pais ao psicanalista e também propõe escutar o que eles têm a dizer. Entretanto, sugere que as entrevistas com pais sejam um trabalho preliminar à análise da criança, e que ao final o psicanalista deveria dizer a eles:

Compreendo muito bem a necessidade que têm de me falar, mas, depois das entrevistas preliminares, que são indispensáveis, ou são vocês que devem vir ou o seu filho. Cada um deve ter o seu psicoterapeuta pessoal. É contraindicado que o mesmo terapeuta tome em tratamento a criança e os pais.¹⁰

Para Dolto, a escuta dos pais deveria ser circunscrita a esse momento específico das entrevistas preliminares, ao final das quais o psicanalista se ocuparia somente da criança. Diferente dos outros autores, ela não sugere nem excluir os pais, como se essa fosse a única forma de manter certa neutralidade em relação à escuta da criança, nem incluí-los como recurso para esclarecer o sintoma da criança. Dolto não acredita que os pais sejam, como propõe Mannoni, a chave da análise da criança, mas também não os considera responsáveis por atrapalhar o bom andamento da análise, como sugerem os que preferem sua exclusão.

Rosine e Robert Lefort, assim como Melanie Klein, assumem uma posição clara de exclusão dos pais do *setting* analítico, porque entendem que essa é a melhor estratégia para que a análise da criança mantenha-se absolutamente independente do discurso dos pais.

Em *A criança no discurso analítico*, Rosine Lefort afirma que "é com o discurso da criança que lidamos. Um discurso que está longe de ser o dos pais".¹¹ Segundo ela, "aos olhos da psicanálise não há uma criança ou um adulto, há um sujeito".¹² Sendo a criança um analisando por inteiro, não haveria razão para escutar os pais, da mesma forma como ocorre

10 DOLTO, F. 1990, p.3.

11 LEFORT, R. 1991, p.11.

12 Idem, p.17.

nas análises dos adultos. Robert Lefort insiste, nesse mesmo livro, que "não há especificidade na psicanálise de crianças. A estrutura, o significante e a relação com o Outro não concernem de maneira diferente à criança e ao adulto".¹³

No entanto, que sejam os pais, e não a criança, que procuram o analista, é considerada por Robert Lefort uma dificuldade na prática psicanalítica com crianças. Mas ele não propõe um manejo para tal dificuldade.

Os riscos de não se ocupar dessa dificuldade são lembrados por Ana Maria Sigal de Rosenberg, em *O lugar dos pais na psicanálise de crianças*, onde afirma que a presença dos pais é uma das armadilhas da clínica com crianças e que, muitas vezes, "se não abrimos um espaço de escuta para os adultos, a análise da criança não se torna possível".¹⁴ Por outro lado, há também o risco, lembrado por Silvia Bleichmar no mesmo livro, de que ao escutar os pais a "fascinação da história" seja um obstáculo para a escuta da criança.

Alicia Hartmann e Carlos Tkach, em *Niños en psicoanálisis*, embora também considerem que a análise deva centrar-se na criança, propõem uma reflexão sobre a presença dos pais nas análises dos filhos que, segundo eles, pode ser compreendida de duas maneiras: como fato fenomênico ou como efeito da estrutura.

Como fato fenomênico, os pedidos, perguntas, demandas ao analista a respeito da análise delimitam um lugar e marcam um movimento particular na transferência. Como feito de estrutura, a criança está presa em sua posição de dependência frente ao adulto e sua pergunta em relação à castração do Outro e à própria castração está colocada ao desejo parental.¹⁵

Sugerem o manejo da transferência como resposta analítica à presença dos pais considerando, inclusive, que esse manejo pode ter como consequência o pedido de análise por parte de um ou ambos os pais. Quando isso acontece, entendem que aquele que faz o pedido deve ser encaminhado a outro analista.

Para eles, o discurso dos pais não deve ser utilizado para interpretar o discurso da criança. O que os autores propõem, é oferecer aos pais uma escuta no sentido analítico, na qual seu discurso seria remetido à

ordem de seu próprio desejo. Segundo eles, a intervenção com os pais não teria qualquer relação com a análise da criança, sendo, antes, um trabalho distinto e preliminar a essa análise.

Para Hartmann e Tkach, ainda que a criança esteja sujeita à presença dos pais – e disto não se pode curá-la – ela poderá "colocar-se de maneira distinta frente à pergunta pela castração e desejo do Outro".¹⁶ Os autores irão, portanto, refutar a ideia das tradicionais anamneses, não apenas por entenderem que a escuta dos pais não deveria ter por objetivo fornecer qualquer esclarecimento à análise da criança, mas principalmente porque se a escuta analítica tem como condição a perda de todo referente, um referente que poderia obstruir a escuta da criança seria a história.

Posição semelhante é adotada por Alba Flesler que, em *A psicanálise de crianças e o lugar dos pais*, sugere distinguir os pais reais dos pais fantasmáticos, considerando o tema da transferência. Para ela, os pais reais são os da infância em curso, mas o psicanalista deve estar atento à forma como a criança toma fantasmaticamente tal presença.

De modo geral temos, então, de um lado, autores que consideram a escuta dos pais fundamental na própria compreensão do sintoma da criança, e que portanto oferecem um lugar de escuta aos pais, no qual seu discurso está a serviço da análise da criança. De outro lado, estão autores que entendem que a análise da criança deve e pode ser feita de maneira totalmente independente do discurso dos pais e que, por essa razão, consideraram problemática sua presença, propondo sua exclusão do tratamento e encaminhando-os a outro psicanalista, quando necessário.

Este livro parte, portanto, de um problema clínico – a presença dos pais se impõe na clínica psicanalítica com crianças desde o início – e de uma dificuldade teórica – são muitas as propostas de manejo dos psicanalistas de crianças para essa presença.

Nossa hipótese é a de que este problema clínico pode ser abordado na perspectiva da estrutura que está em jogo no pedido de tratamento para uma criança, uma estrutura que *inclui os pais desde o início*.

Optamos, então, por circunscrever o problema às *entrevistas preliminares*, considerando que, neste período inicial de todo tratamento de criança, é inevitável que o psicanalista decida o destino e o manejo das queixas dos pais, esteja ele advertido ou não das razões e das con-

13 - Idem, p.13.

14 - ROSENBERG, A. M. S. de (org.) 1994, p.26.

15 - HARTMANN, A.; TKACH, C. 1989, p.57-58.

16 - Idem, p.58.

seqüências de sua escolha.

Com o auxílio das teorias de Lacan sobre a constituição do sujeito, procuramos mostrar a importância de considerar o triângulo pai-mãe-criança enquanto uma estrutura na qual é possível situar *funções, lugares e sujeitos* para, finalmente, propor, a partir dessa reflexão teórica, um manejo clínico do lugar dos pais na psicanálise de crianças.

Na **Parte I** buscaremos, na teoria lacaniana, conceitos que permitam esclarecer o *lugar* e a *função* dos pais na constituição psíquica da criança. Essa será a base a partir da qual, na **Parte II**, proporemos um manejo clínico da presença dos pais que possa ser considerado rigorosamente compatível com as concepções de *sujeito*, de inconsciente e de tratamento psicanalítico com as quais o psicanalista opera na clínica.

PARTI

PARTE 1



o casal parental e a constituição do sujeito

Em *Nota sobre a criança*, Lacan (1969) afirma que um filho responde com seu sintoma ao que há de sintomático na estrutura familiar.

Conforme vimos na **Introdução**, há psicanalistas que estabelecem uma relação tão direta entre a resposta sintomática da criança e o que se passa com os pais, que chegam a sugerir que sem a análise dos pais não seria possível a análise da criança. No limite, alguns propõem haver casos em que seria necessário tratar os pais para obter efeitos sobre a criança.

De outro lado, há analistas que argumentam que, independente do que se passa na estrutura familiar, a resposta é da criança e, como tal, deve ser escutada. Que a análise é da criança, que é seu inconsciente que está em questão e não a realidade externa e que, portanto, não cabe ao psicanalista da criança ocupar-se dos pais.

De um lado e de outro, entretanto, a importância dos pais na constituição psíquica da criança não é ignorada. Qualquer que seja a posição clínica adotada, parte-se do pressuposto de que o sujeito não é inato, o sujeito se constitui. E que o vínculo da criança com aqueles que dela se ocupam desde o nascimento tem papel fundamental nessa constituição.

Mesmo Lacan, que preferiu dar destaque à função da fala e ao campo da linguagem para abordar a constituição do sujeito, jamais ignorou ou desprezou a importância de um suporte concreto necessário a essa constituição.

Em 1969, Lacan insistirá na importância da família conjugal,

responsável, segundo ele, pelo "irredutível de uma transmissão", da qual depende a constituição do sujeito. Para Lacan, se as utopias comunitárias fracassaram em seu projeto de abolir a família, é porque esse irredutível parece depender daquilo que, na família conjugal, é sustentado pelas funções denominadas materna e paterna, funções que estamos habituados a identificar como sendo as da mãe e do pai.

Da mãe, na medida em que seus cuidados trazem a marca de um interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas. Do pai, na medida em que seu nome é o vetor de uma encarnação da lei no desejo.¹

Trata-se de funções que Lacan articula ao desejo, à lei simbólica e à falta, o que conduzirá, conforme veremos adiante, ao significante e à linguagem – permitindo, inclusive, esclarecer que não se trata necessariamente do pai e da mãe. Abre-se, portanto, a possibilidade de reflexão sobre as novas configurações familiares, considerando sempre a função de suporte necessária para a transmissão que constitui o sujeito.

Nesse ponto reside a dificuldade do psicanalista na clínica com crianças: como relacionar a presença daqueles que concretamente compõem o ambiente familiar da criança com as funções paterna e materna, necessárias à constituição de um sujeito? Não seria essa dificuldade a razão para haver tantas propostas de manejo da presença dos pais no tratamento das crianças?

Não é incomum que diante da dificuldade em manejar a presença dos pais, os psicanalistas de crianças recorram às teorias sobre a constituição do sujeito. Pode o referencial teórico acerca das funções necessárias à constituição do sujeito fornecer subsídios para o manejo clínico da presença dos pais nos tratamentos de seus filhos? Como a teoria psicanalítica sobre a constituição do sujeito pode contribuir para o manejo clínico?

É o que discutiremos nos próximos capítulos, tomando da teoria lacaniana conceitos que permitam esclarecer o lugar e a função dos pais na constituição do sujeito, a fim de delimitar seu alcance para estabelecer coordenadas a partir das quais tanto a clínica com crianças como o manejo com os pais podem ser situados.

1 LACAN, J. (1969). p.373.

capítulo 1

a mãe - a função materna - o Outro

O ser humano, ao nascer, é prematuro e completamente dependente. Sem um outro que o ampare e acolha, ele não sobrevive. A satisfação de suas necessidades mais básicas passa por um circuito que tem, no outro e em sua interpretação, seu suporte essencial. Aquele que cuida da criança traduz o choro em necessidade. Supõe, no grito, uma demanda. Interpreta.

Mas o choro do bebê, contrariamente ao que supõe a mãe, não é, desde o início da vida, um choro endereçado. No início da vida, um choro é apenas a expressão de um desconforto, de um desprazer. É a evidência de que algo se passa com o bebê. O endereçamento só pode ocorrer quando há um *eu* de onde ele parte e um *outro* para o qual se dirige. Sem a distinção *eu-outro*, a demanda da criança não passa de uma suposição da mãe.

A mãe – ou aquele que acolhe a criança no nascimento – supõe uma demanda e oferece uma resposta que faz cessar o desconforto. Ao fazê-lo, tanto ela como a criança são capturadas em um circuito interpretativo que Winnicott nomeou com a expressão "loucura necessária das mães".¹ O choro não apenas é interpretado pela mãe como tendo um sentido – fome, frio, sono – mas um sentido que sugere endereçamento, demanda: se o bebê chora é porque demanda algo dela.

A expressão de Winnicott aponta um duplo viés dessa função interpretativa das mães. De um lado, que ela envolve um traço de lou-

1 WINNICOTT, D. W. 1988, p.30.

cura, porque se baseia em uma atribuição complexa de sentido onde, a princípio, não há sentido algum. E de outro, que ela é necessária, porque dela depende não apenas a satisfação das necessidades básicas da criança, mas também sua constituição psíquica.

Lacan destaca, nesse circuito que configura o laço inicial mãe-criança, que se trata da linguagem. O choro exige tradução, requer atribuição de sentido, e a mãe, porque entra no circuito fornecendo sentido, opera enquanto suporte privilegiado do campo da linguagem para a criança. Trata-se de uma função, a da mãe, que implica um lugar, o da linguagem, lugar do "tesouro do significante"², que ele denominou grande Outro, A.³

É um circuito que captura a criança e a mãe, no qual "tudo o que se realiza no S, sujeito, depende do que se coloca de significantes no A", afirmará Lacan.⁴ Para ele, tal circuito revela essa dependência do ser humano no nascimento, uma dependência que ultrapassa a satisfação das necessidades básicas, ela é também dependência do campo da linguagem.

A experiência do Imperador Frederico II, no século XIII, relatada pelo sociólogo Ely Chinoy⁵ é uma das mais impactantes revelações dessa dependência. Esse imperador queria descobrir que língua desenvolveriam crianças que não tivessem contato com nenhum tipo de linguagem desde o nascimento. Para isso, ordenou que se oferecessem todos os cuidados básicos às crianças, sem que, no entanto, se falasse com elas. O resultado que obteve é a evidência contundente de que a satisfação das necessidades não é suficiente para suprir algo que se encontra na dependência deste Outro lugar: todas as crianças morreram.

Foi para dar destaque ao lugar da linguagem que Lacan recorreu à expressão Outro primordial. Forjada no início de seu ensino, ela tinha por objetivo enfatizar que não se trata necessariamente da presença da mãe, mas de uma função e de seu efeito no estabelecimento de um lugar. O Outro primordial é o nome dado por Lacan à função da mãe como suporte da linguagem nos cuidados primordialmente dispensados à criança, é sua maneira de destacar a função de suporte do lugar do

Outro exercida pelo cuidador.

Nomear a mãe de Outro primordial é insistir na importância desse lugar a que a função dá suporte, o do grande Outro, e marcar, ao mesmo tempo, que o sujeito é efeito da linguagem, que é pela linguagem que o sujeito se constitui. O sujeito se define, assim, como efeito da inscrição do ser⁶ no campo da linguagem. É o que Lacan desenha em seu pequeno grafo⁷, célula elementar da constituição do sujeito:



Aos poucos, talvez para evitar os tão comuns desvios na interpretação do papel da mãe (ou do cuidador primordial) nessa função, Lacan se referirá cada vez menos a esse exercício interpretativo das necessidades, passando a insistir na importância do Outro como o lugar da linguagem da qual o sujeito é efeito.

A rigor trata-se, portanto, do Outro, da linguagem enquanto lugar, do tesouro dos significantes – e não da mãe. A rigor, a mãe não é o grande Outro. O Outro enquanto lugar da linguagem não se reduz, nem se limita, à presença da mãe na vida de uma criança.

Mas se o próprio Lacan chamou-a de Outro primordial, foi para articular o lugar à função e lembrar que o circuito interpretativo no qual uma criança é capturada ao nascer depende de um suporte concreto.

A linguagem, definida por Lacan como campo pré-existente a todo nascimento⁸, não é, portanto, condição suficiente para a constituição

2 LACAN, J. (1960), p.820.

3 Do francês, *Autre*, que Lacan escreve com A maiúsculo para distingui-lo do outro grafado com minúscula, o semelhante, *autre*. O grande Outro é definido como o campo da linguagem, como o tesouro dos significantes. Mas é também o lugar do inconsciente, lugar desde onde o sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida.

4 LACAN, J. (1956-57), p.163.

5 CHINOY, E. 1971, p.116.

6 Escrito por Lacan Δ, ser de necessidade, definido como o ser mítico anterior à inscrição no campo da linguagem que constitui o sujeito. Lacan, 1960a, p.819.

7 Na definição de Lacan, o grafo contempla o "sujeito definido por sua articulação pelo significante" (1960a, p.819-820), onde o eixo que vai de S a S' representa a cadeia significante, Δ o ser mítico de necessidade e S, o sujeito. Lacan partirá dessa célula mínima que constitui o sujeito para montar, ao longo do Seminário 5 e do Seminário 6, seu grafo do desejo, cuja estrutura é apresentada em "Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano". Em seu grafo do desejo, Lacan escreverá os elementos que compõem a "estrutura de ficção" (Idem, p.822).

8 LACAN, J. (1957), p.498.

cura, porque se baseia em uma atribuição complexa de sentido onde, a princípio, não há sentido algum. E de outro, que ela é necessária, porque dela depende não apenas a satisfação das necessidades básicas da criança, mas também sua constituição psíquica.

Lacan destaca, nesse circuito que configura o laço inicial mãe-criança, que se trata da linguagem. O choro exige tradução, requer atribuição de sentido, e a mãe, porque entra no circuito fornecendo sentido, opera enquanto suporte privilegiado do campo da linguagem para a criança. Trata-se de uma função, a da mãe, que implica um lugar, o da linguagem, lugar do "tesouro do significante"², que ele denominou grande Outro, A.³

É um circuito que captura a criança e a mãe, no qual "tudo o que se realiza no S, sujeito, depende do que se coloca de significantes no A", afirmará Lacan.⁴ Para ele, tal circuito revela essa dependência do ser humano no nascimento, uma dependência que ultrapassa a satisfação das necessidades básicas, ela é também dependência do campo da linguagem.

A experiência do Imperador Frederico II, no século XIII, relatada pelo sociólogo Ely Chinoy⁵ é uma das mais impactantes revelações dessa dependência. Esse imperador queria descobrir que língua desenvolveriam crianças que não tivessem contato com nenhum tipo de linguagem desde o nascimento. Para isso, ordenou que se oferecessem todos os cuidados básicos às crianças, sem que, no entanto, se falasse com elas. O resultado que obteve é a evidência contundente de que a satisfação das necessidades não é suficiente para suprir algo que se encontra na dependência deste Outro lugar: todas as crianças morreram.

Foi para dar destaque ao lugar da linguagem que Lacan recorreu à expressão Outro primordial. Forjada no início de seu ensino, ela tinha por objetivo enfatizar que não se trata necessariamente da presença da mãe, mas de uma função e de seu efeito no estabelecimento de um lugar. O Outro primordial é o nome dado por Lacan à função da mãe como suporte da linguagem nos cuidados primordialmente dispensados à criança, é sua maneira de destacar a função de suporte do lugar do

Outro exercida pelo cuidador.

Nomear a mãe de Outro primordial é insistir na importância desse lugar a que a função dá suporte, o do grande Outro, e marcar, ao mesmo tempo, que o sujeito é efeito da linguagem, que é pela linguagem que o sujeito se constitui. O sujeito se define, assim, como efeito da inscrição do ser⁶ no campo da linguagem. É o que Lacan desenha em seu pequeno grafo⁷, célula elementar da constituição do sujeito:



Aos poucos, talvez para evitar os tão comuns desvios na interpretação do papel da mãe (ou do cuidador primordial) nessa função, Lacan se referirá cada vez menos a esse exercício interpretativo das necessidades, passando a insistir na importância do Outro como o lugar da linguagem da qual o sujeito é efeito.

A rigor trata-se, portanto, do Outro, da linguagem enquanto lugar, do tesouro dos significantes – e não da mãe. A rigor, a mãe não é o grande Outro. O Outro enquanto lugar da linguagem não se reduz, nem se limita, à presença da mãe na vida de uma criança.

Mas se o próprio Lacan chamou-a de Outro primordial, foi para articular o lugar à função e lembrar que o circuito interpretativo no qual uma criança é capturada ao nascer depende de um suporte concreto.

A linguagem, definida por Lacan como campo pré-existente a todo nascimento⁸, não é, portanto, condição suficiente para a constituição

2 LACAN, J. (1960), p.820.

3 Do francês, *Autre*, que Lacan escreve com A maiúsculo para distingui-lo do outro grafado com minúscula, o semelhante, *autre*. O grande Outro é definido como o campo da linguagem, como o tesouro dos significantes. Mas é também o lugar do inconsciente, lugar desde onde o sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida.

4 LACAN, J. (1956-57), p.163.

5 CHINOY, E. 1971, p.116.

6 Escrito por Lacan Δ, ser de necessidade, definido como o ser mítico anterior à inscrição no campo da linguagem que constitui o sujeito. Lacan, 1960a, p.819.

7 Na definição de Lacan, o grafo contempla o "sujeito definido por sua articulação pelo significante" (1960a, p.819-820), onde o eixo que vai de S a S' representa a cadeia significante, Δ o ser mítico de necessidade e s, o sujeito. Lacan partirá dessa célula mínima que constitui o sujeito para montar, ao longo do Seminário 5 e do Seminário 6, seu grafo do desejo, cuja estrutura é apresentada em "Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano". Em seu grafo do desejo, Lacan escreverá os elementos que compõem a "estrutura de ficção" (Idem, p.822).

8 LACAN, J. (1957), p.498.

do sujeito. O ser humano nasce imerso no campo da linguagem, mas o sujeito só se constitui como efeito de uma operação que o inscreve nesse campo.

São várias as maneiras de abordar essa operação, ao longo do ensino de Lacan.

Nos primeiros seminários, chamou-a de *estádio do espelho*, dando destaque à função do *eu* que resulta da inscrição do ser no campo da linguagem e situando, no lugar do espelho, a linguagem, suporte dessa operação da qual o sujeito é efeito. Depois, em seu projeto de *retorno a Freud*, vai localizá-la no complexo de Édipo, atribuindo à própria estrutura familiar a função de suporte significante da estrutura da metáfora da qual o sujeito é efeito. E finalmente, quando propõe sua teoria da alienação, se preocupará em esclarecer que embora seja pela linguagem que o sujeito se constitui, o sujeito não se reduz ao significante, ao sentido ao qual ele se aliena.

Qualquer que seja a teoria sobre a constituição do sujeito em Lacan, trata-se sempre do mesmo ponto de partida: o sujeito só se constitui na e pela linguagem.

Estádio do espelho

É na óptica que Lacan encontrará seu primeiro modelo para abordar o efeito da inscrição do ser no campo da linguagem.

Logo nos primeiros seminários, sua preocupação centrava-se na formação do *eu*, e seu modelo, depois chamado *esquema óptico*, servirá de metáfora para a abordagem da operação psíquica da qual resulta esse *eu*. Segundo Lacan, "esse esqueminha não passa de uma elaboração muito simples do que tento lhes explicar há anos, com o estágio do espelho".⁹

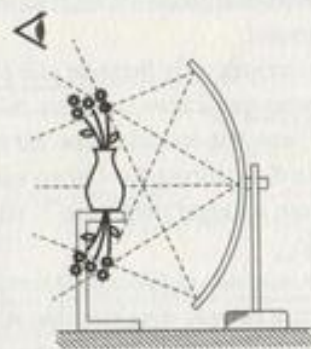
O exemplo paradigmático da reação de júbilo da criança que reconhece sua própria imagem no espelho, retirado do experimento de Henri Wallon¹⁰ será, para Lacan, a evidência mais clara e mais precoce da constituição do *eu*. O *eu* confunde-se com a imagem refletida no espelho, ilusão de unidade que a forma totalizante do corpo dá ao ser.

O *estádio do espelho* é, na definição de Lacan, "a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem".¹¹ A reação da criança, antes indiferente à presença do espelho, atesta tal transforma-

ção. Uma transformação que exige mais que a simples presença de um espelho, depende também da presença daquele que segura a criança e nomeia a imagem projetada no espelho como sendo a dela. Ou seja, de alguém que dê suporte à linguagem e ao significante.

A apreensão de si depende, portanto, do Outro enquanto o lugar do qual o sujeito recolhe os significantes que resultam no *eu* e na "função de desconhecimento que o caracteriza"¹². O *eu* é, na definição de Lacan, fruto da alienação ao campo do Outro, ao significante que dará suporte à imagem. Mas uma alienação necessária e estruturante, que transforma a fragmentação corporal em unidade ilusória de si, reconhecida com júbilo na imagem projetada no espelho.

Lacan encontrará na física o modelo para abordar essa constituição ilusória e alienante do *eu*: o esquema de Bouasse. Nele, a presença de um espelho côncavo projeta um buquê para dentro de um vaso, produzindo a ilusão de unidade do objeto:



O esquema é o recurso por meio do qual Lacan mostrará que um espelho pode produzir a ilusão que transforma fragmentação, em unidade ilusória.

O espelho é, ao mesmo tempo, suporte fundamental dessa transformação e fonte de alienação e desconhecimento. Por isso, será comparado à função do Outro, lugar do significante a partir do qual o *eu* adquire consistência.

O Outro, tal como o espelho, é o lugar a partir do qual a imagem

9 LACAN, J. (1953-54), p.147.

10 WALLON, H. P. H. (1879-1962). Psicólogo, médico, filósofo e político francês.

11 LACAN, J. (1949), p.97.

12 LACAN, J. (1949), p.103.

se sustenta como *tu és isso*. Nesse sentido, a função da mãe como Outro primordial é também a função do espelho no esquema óptico de Lacan.

A alienação implica, portanto, assujeitamento aos significantes que o sujeito recolhe desse Outro lugar que tem, na função da mãe e daqueles que se ocupam da criança ao nascer, seu suporte concreto.

Mannoni, influenciada pelo ensino de Lacan, dará tamanha ênfase a essa função de suporte do Outro, que irá propor um manejo clínico no qual os efeitos da análise da criança dependeriam da escuta dos pais. Para Mannoni, a função de Outro primordial à qual os pais dão suporte levaria à necessidade da escuta dos pais para interpretar o sintoma da criança. Na mesma linha, a proposta de Durval Checcinatto, que dá título a seu livro, é ainda mais radical, considera que a escuta dos pais tornaria a análise da criança dispensável¹³. Que a escuta dos pais tenha efeitos sobre os filhos é uma fato que a experiência clínica confirma. Mas recolher tais efeitos seria o mesmo que visá-los no manejo clínico? Não haveria um risco, neste caso, de reduzir os pais à função do espelho à qual servem de suporte, pressupondo, do lado da criança, um completo assujeitamento a tal função?

Lembremos que o esquema de Bouasse não é o modelo do sujeito para Lacan, ele é o recurso que Lacan encontra na física para construir seu próprio modelo. E em seu modelo, que ele chamará de esquema óptico, o que se passa com o sujeito e o Outro exige considerar que a "dependência significante ao lugar do Outro"¹⁴ não implica reciprocidade, mas circularidade.

O esquema de Bouasse não esgota a complexidade do que se passa com o sujeito, justamente porque o sujeito não se reduz à imagem do espelho. A alienação, o assujeitamento ao Outro e à imagem à qual o significante dá suporte não tornam o sujeito cativo da imagem, lembrará Lacan no *Seminário 10*.¹⁵ O sujeito não está "condenado a só se ver surgir in initio, no campo do Outro", conforme advertência de Lacan no *Seminário 11*: "isso podia ser assim. Muito bem; de modo algum, de modo algum, de modo algum".¹⁶

Há um detalhe, destacado por Lacan já no artigo sobre o *estádio do espelho*, e retomado no *Seminário 10*, que evidencia a complexidade

13 CHECCINATTO, 2007.

14 LACAN, J. (1964), p.196.

15 LACAN, J. (1962-63), p.54.

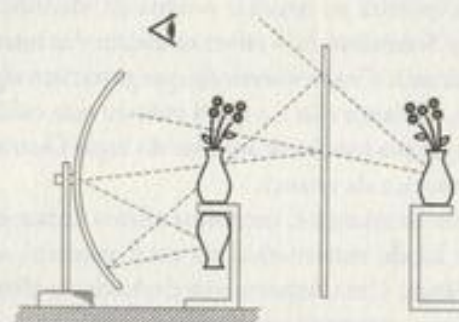
16 Idem (1964), p.199.

da operação que constitui o *eu*.

O júbilo da criança, revelador da ilusão da unidade que o *eu* encontra no espelho, se completa com um giro de cabeça em direção àquele que a segura. Um "gesto pelo qual a criança diante do espelho, voltando-se para aquele que a segura, apela com o olhar para o testemunho que decanta, por confirmá-lo, o reconhecimento da imagem, da assunção jubilatória em que por certo ela já estava".¹⁷

Lacan vê, no gesto de cabeça da criança, um apelo de confirmação e reconhece, nesse apelo, uma evidência da complexidade de uma operação que não se esgota na alienação à imagem do espelho. Para Lacan, a necessidade de confirmação é a evidência de que a criança não é meramente cativa da imagem que a constitui.¹⁸

Há, portanto, dois tempos de reconhecimento no espelho, e Lacan vê a necessidade de incluir ambos em seu esquema. Por isso, acrescenta ao esquema de Bouasse mais um espelho, plano, que permite situar o apelo por confirmação enquanto formação secundária, revelando a complexidade de uma operação que se desdobra em dois tempos.



O primeiro, que é revelado na reação de júbilo da criança diante da unidade reconhecida na imagem¹⁹, corresponde à imagem projetada do

17 LACAN, J. (1960), p.685.

18 No *Seminário 10*, Lacan retomará seu *esquema óptico*, insistindo na importância do que não passa pela imagem especular, de que "nem todo investimento libidinal passa pela imagem especular" (1963-64, p.48-49). Ele insiste, aliás, nesse ponto desde o *Seminário 9*, no qual retoma a teoria sobre a identificação.

19 Que Lacan associará ao *eu ideal*, *I(a)*, narcisismo primário, "um narcisismo que se relaciona à imagem corporal. [...] Ela faz a unidade do sujeito e [...] se liga ao sentimento, ao *Selbstgefühl*, que o ser humano, o *Mensch*, tem do seu próprio corpo. Esse primeiro narcisismo se situa, se vocês

espelho côncavo; e o segundo, que se torna evidente no gesto de apelo à confirmação, corresponde à segunda imagem, projetada no espelho plano a partir da imagem do primeiro espelho, imagem da imagem.²⁰

Entre um tempo e outro, no intervalo que dá a distância entre a imagem unificada de si e a necessidade da confirmação, na distância do *ideal do eu* ao *eu ideal*, está o *sujeito*. É essa intransponível distância, para sempre marcada como intervalo, como *hiância*, como *falta*, que dá ao *sujeito* seu lugar. O esquema permite, portanto, mostrar que o *sujeito* é, por definição, distinto do *eu*.

Os efeitos da escuta dos pais sobre a criança podem, então, ser compreendidos do lado da função especular para a qual eles servem de suporte. Trata-se de efeitos que variam desde os mais sutis até aqueles em que se produz um desenlace do sintoma da criança. Poderiam tais efeitos serem diretamente visados no tratamento da criança?

Se o *esquema óptico* mostra que a criança, em sua resposta ao que se apresenta como espelho do lado dos pais, não está cativa desse espelho, que a necessidade do Outro a partir do qual o *sujeito* se constitui não resulta em um *sujeito* que seria mero reflexo especular desse Outro – é nisso que Lacan insistirá ao retomar o tema da identificação, desde o *Seminário 9* até o *Seminário 11* – talvez os efeitos das intervenções com os pais sejam mais sutis e imprevisíveis do que gostariam alguns analistas.

Para Lacan, a criança não é o que a mãe ou seus cuidadores dizem que ela é, ainda que sua função de suporte do lugar Outro seja essencial à constituição psíquica da criança.

Se o sintoma da criança é, conforme afirma Lacan em 1969, uma resposta ao que há de sintomático no casal parental, ainda assim a resposta é da criança. Uma resposta que depende da alienação aos significantes do Outro, mas que inclui também a hiância, o desencontro e a necessidade da confirmação como parte fundamental de sua posição, atestada pelo gesto de virada de cabeça da criança. *Quem sou? Sou mesmo essa imagem que, por um instante, vislumbrei no espelho?* O *sujeito* não se reduz à resposta alienada à qual o *eu* dá consistência porque, segundo Lacan, a alienação ao campo do Outro inclui um resto, a partir do qual

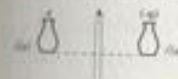
quiserem, no nível da imagem real do meu esquema [...]” (LACAN, 1953-54, p.147-148).

20 A essa segunda imagem Lacan chama narcisismo secundário, articulando-o ao *ideal do eu*. “No homem, ao contrário [do que acontece com os animais], a reflexão no espelho manifesta uma possibilidade noética original, e introduz um segundo narcisismo” (LACAN, 1953-54, p.148).

a pergunta sobre o que é existir tem lugar.²¹

É necessário acrescentar, portanto, à função do espelho, função de suporte do lugar do Outro, tesouro dos significantes, uma outra função, a partir da qual a pergunta, a hiância, a falta, tem lugar. É o que Lacan destaca como fundamental em sua teoria do complexo de Édipo, conforme veremos nos próximos capítulos.

21 É a esse resto que Lacan faz referência ao retomar, no *Seminário 10*, seu *esquema óptico*, cuja forma acabada será a seguinte:



Daí Lacan propor, no *Seminário 11*, que a alienação ao campo do Outro inclui, logicamente, esse resto e, conseqüentemente, a separação. Segundo Lacan, “a alienação consiste nesse *vel* que [...] condena o *sujeito* a só aparecer nessa divisão [...], se ele aparece de um lado com sentido, produzido pelo *significante*, do outro ele aparece como *afimise* (1964, p.199).

capítulo 2

a criança - o falo

O conceito fundamental para abordar a função da falta, da hiância a partir da qual o sujeito se distingue do *eu*, é o falo.

A teoria sobre o complexo de Édipo e as funções que organizam as relações entre pai-mãe-criança são o eixo a partir do qual Lacan situa o falo na constituição do sujeito.

Lacan destacará dois aspectos a considerar para compreender o lugar e a função do falo no complexo de Édipo e na relação pai-mãe-criança. De um lado, o do falo enquanto lugar que a criança ocupa para a mãe e as consequências, para a criança, desse lugar que ocupa. De outro, o de sua função na própria subjetividade, tanto da mãe, como da criança e também do pai.

É no *Semindrio 4* e no texto "A significação do falo" (1958) que Lacan irá propor essa discussão, recuperando o conceito da teoria de Freud e mostrando que ele está na base de toda investigação freudiana sobre a relação de objeto.

Lacan insistirá na importância de situar o falo como o objeto ao qual o desejo está articulado, desejo que se estrutura no complexo de Édipo, a partir da castração.

Segundo Freud, os caminhos da sexualidade dependem da forma como a diferença anatômica é interpretada, uma interpretação que tem o falo enquanto elemento essencial da organização genital infantil.

Os meninos, porque têm no corpo um órgão que dá consistência imaginária ao falo, tendem a identificar-se como fáticos e as meninas,

pela ausência do órgão, como castradas. A posse ou a não-posse do pênis, interpretável como presença ou falta fálica, é o elemento organizador da sexualidade e determina os caminhos da identidade sexual e da escolha de objeto, tanto do menino como da menina.

Não existe, portanto, inscrição simbólica própria ao masculino e ao feminino, o que existe é o atributo fálico a partir do qual a sexualidade é interpretada. Ser desprovido desse atributo fálico é considerado como equivalente a ser castrado.¹ Por isso, Lacan afirmará que a relação com o falo "é de interpretação especialmente espinhosa na mulher".²

Um dos destinos possíveis do complexo de castração na mulher seria, segundo Freud, a demanda, endereçada ao pai, de que o falo lhe seja restituído sob a forma simbólica de um bebê. Em "A dissolução do complexo de Édipo" (1924), Freud afirmará que a menina "desliza – ao longo de uma equação simbólica, poder-se-ia dizer – do pênis para um bebê. Seu complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê como presente – dar-lhe um filho".³ A maternidade seria, na concepção freudiana, a saída feminina para o complexo de Édipo, na qual o desejo se articula ao falo, cujo representante privilegiado seria o filho.

Retomando os passos de Freud, Lacan afirmará:

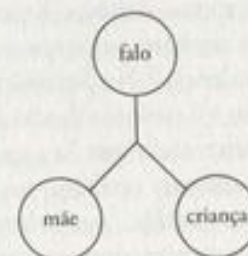
Freud, por seu lado, nos diz que a mulher tem, dentre suas faltas de objetos essenciais, o falo, e que isso está estreitamente ligado à sua relação com a criança. Por uma simples razão – se a mulher encontra na criança uma satisfação é, muito precisamente, na medida em que encontra nesta algo que atenua, mais ou menos bem, sua necessidade de falo, algo que o satura.⁴

Segundo Lacan, "existe na mãe, ao lado da criança, a exigência do falo, que a criança simboliza ou realiza mais ou menos"⁵ e esse é o ponto de partida que dá o eixo da relação mãe-criança. Trata-se, portanto, de uma relação que é apenas aparentemente dual, porque é mediada pelo falo.

Todo o progresso que pode conhecer a relação aparentemente dual da criança com a mãe é, de fato, marcado por esse elemento essencial, do qual a experiência da análise de sujeitos femininos nos dá a certeza, e que é o ponto de referência, o eixo, que Freud manteve com firmeza até o fim no que diz respeito à

sexualidade feminina: a criança só intervém como substituto, compensação, em suma, numa referência, qualquer que seja ela, ao que falta à mulher.⁶

No *Seminário 4*, Lacan propõe um esquema para representar essa relação aparentemente dual, na qual o falo é o elemento terceiro.⁷



Ao destacar a importância do falo como elemento terceiro na relação mãe-criança, Lacan acrescenta uma nova perspectiva àquela na qual a função da mãe está ligada ao lugar do Outro primordial, suporte primeiro do campo da linguagem para a criança. A perspectiva do *desejo* materno.

Não se trata de uma mudança de perspectiva, mas de um acréscimo. Se a mãe, capturada no circuito da função interpretativa, ocupa o lugar de Outro primordial, é porque a criança, no lugar do falo, também tem uma função para a mãe, ela representa aquilo que lhe falta, o objeto de seu desejo.

Lacan considera que o lugar do Outro, ao qual a mãe dá suporte, tem relação com o lugar fálico que a criança ocupa em seu desejo, ou seja, que se trata de um enlace que é, ao mesmo tempo, fundamental para a mãe e também para a constituição psíquica da criança.

A mãe, enquanto suporte do lugar do Outro, é também suporte de uma função a partir da qual o desejo tem lugar. "A dimensão do Outro amplia-se um pouquinho aqui. Com efeito, ele já não é unicamente a sede do código"⁸, afirmará Lacan, no *Seminário 5*.

O desejo materno é, portanto, um acréscimo à compreensão da

1 LACAN, J. (1956-57), p.96.

2 Idem (1958), p.693.

3 FREUD, S. (1924), p.223.

4 LACAN, J. (1956-57), p.71.

5 Idem, p.56.

6 Idem, p.247.

7 Idem, p.28.

8 LACAN, J. (1957-58), p.156.

função de espelho da mãe, ao lugar de Outro primordial ao qual ela dá suporte, porque revela o mecanismo em torno do qual a estrutura é montada, porque esclarece que tanto a mãe como a criança são capturadas nesse mecanismo pela posição da criança que, ao representar o falo, tem também uma função, sustentar o ideal de completude da mãe.

A criança ocupa este lugar que Freud nomeia *sua majestade o bebê*, expressão que não apenas define o lugar fálico da criança para seus pais, mas que lembra também que o narcisismo de ambos está em jogo quando se trata da criança.¹⁰ No *Seminário 17*, Lacan será ainda mais assertivo para lembrar a função do desejo da mãe para a constituição psíquica da criança, afirmando que "o papel da mãe é o desejo da mãe".¹¹ Na mesma época, afirmará também, em "Nota sobre a criança", que a função da mãe é transmitida "por intermédio de suas próprias faltas".¹² Essa estrutura se organiza, portanto, em torno do ideal fálico representado pela criança.

Quando a criança apresenta um sintoma, não é incomum que se produza, nos pais, um certo abalo narcísico, em função do lugar que a criança ocupa para cada um deles. O sintoma da criança desloca-a do lugar fálico idealizado e os pais são frequentemente tomados por um sentimento de fracasso em relação aos próprios papéis, igualmente idealizados.

Se na clínica psicanalítica com crianças está em questão, justamente, essa montagem idealizada em torno do lugar fálico representado pelo filho, como não considerá-lo no manejo e na escuta dos pais? Se a angústia dos pais pelo fracasso dos ideais depositados no filho está, implícita ou explicitamente, presente em sua demanda, como desconsiderar que um pedido de tratamento é, em certa medida, uma demanda de restituição desse ideal? Não deveria a escuta dos pais levar tal demanda em conta? Quando o lugar que a criança ocupa para cada um dos pais orienta e define os caminhos da escuta do psicanalista, essas são algumas das questões que se colocam para o manejo da clínica.

Mas é na perspectiva da criança e das consequências do lugar fálico

9 FREUD, S. (1914).

10 Embora Freud tenha dado destaque ao lugar simbólico do filho na saída do Édipo feminino, também no Édipo masculino é o lugar do falo que está em questão. Que o homem, portador do órgão que representa o falo, tenha a ilusão de ter o falo, não exclui que a dimensão simbólica da falta opera, também, sobre ele.

11 LACAN, J. (1969-70), p.105.

12 Idem (1969), p.369.

que ocupa, que encontraremos as maiores contribuições de Lacan nos seminários 4 e 5.

Depois de situar, no *Seminário 4*, o falo como elemento terceiro na relação aparentemente dual da mãe com o filho, Lacan recorrerá, no *Seminário 5*, à teoria do complexo de Édipo para discutir seus efeitos sobre a criança.

"Para agradar a mãe, é necessário e suficiente ser o falo"¹³, afirmará Lacan sobre o primeiro tempo do complexo de Édipo, que ele chamará "etapa fálica primitiva". A criança é o falo, identificada imaginariamente a ele em um tempo mítico definido por Lacan como o da identificação especular inicial da criança ao objeto do desejo materno: "no primeiro tempo e na primeira etapa, portanto, trata-se disto: o sujeito se identifica especularmente com aquilo que é objeto do desejo da mãe. Essa é a etapa fálica primitiva [...]".¹⁴ É um tempo em que a identificação primitiva "faz o *eu* do sujeito surgir no lugar da mãe como Outro, enquanto o *eu* da mãe transforma-se no Outro dele".¹⁵

Esse é o tempo que se define pela engrenagem que inclui a criança no lugar de falo e a mãe em sua função de suporte privilegiado da linguagem, lugar do Outro primordial. Tempo miticamente situado por Lacan como aquele em que o eu da criança só pode surgir neste Outro lugar, do qual a mãe é o suporte. Por isso, "a primeira relação de realidade desenha-se entre a mãe e o filho, e é aí que a criança experimenta as primeiras realidades de seu contato com o meio vivo".¹⁶ Não apenas é um tempo em que a criança está identificada especularmente ao falo, conforme definição de Lacan do *Seminário 4*, mas também é o tempo da satisfação primordial ideal plena. Tempo que irá adquirir, retroativamente, uma função essencial, a de situar um tempo mítico da satisfação plena que teria sido a relação mãe-criança, tempo representado pelo gozo incestuoso, no Édipo, pelo Das Ding freudiano. Trata-se de um tempo que, para o sujeito, tem uma função que é psíquica, chamada no *Seminário 5* momento da demanda satisfeita:

Lembrem-se do esquema do que eu poderia chamar de momento simbólico ideal primordial, que é totalmente inexistente. O momento da demanda satisfeita é representado pela simultaneidade de intenção, na medida em que

13 Idem (1957-58), p.198.

14 Idem.

15 Idem, p.209.

16 Idem, p.186.

ela se manifeste como mensagem, e da chegada dessa mensagem como tal ao Outro. [...] Se esse momento existe, a sequência, ou seja, o que sucede à mensagem, à sua passagem para o Outro, é ao mesmo tempo realizado no Outro e no sujeito, e corresponde ao que é necessário para que haja satisfação. Esse é, muito precisamente, o ponto de partida que convém para vocês compreenderem que isso nunca acontece.¹⁷

Não há correspondência absoluta entre demanda e satisfação, assim como não há correspondência entre o ser e o significante que o define no lugar do Outro. Ainda que o significante seja o que dá lugar ao ser, traduzindo a existência na fonte de desconhecimento que o *eu* empresta ao sujeito, a correspondência entre o ser e sua apreensão no lugar do Outro é mítica.

Lacan dará a essa não correspondência uma função e um lugar central na relação do sujeito com o falo.

Desde o estádio do espelho, passando pelo Édipo e finalmente no Seminário 11, com a teoria sobre a alienação-separação, Lacan insistirá nessa discordância entre o ser e o sentido que se encontra no lugar no Outro.

Na teoria do espelho, Lacan já localizava essa discordância na sutileza do giro de cabeça da criança em direção àquele que a segura, no momento em que reconhece sua imagem no espelho, evidência de que o sujeito não fica reduzido ao *eu*, de que ele não é cativo da imagem na qual se reconhece. Para Lacan, esse giro de cabeça é revelador de que há discordância entre o ser e a imagem do *eu* que lhe dá consistência e ilusão de unidade.

Essa mesma discordância, que permite ver que o ser não se reduz ao significante em que ele se define, também será localizada por Lacan na teoria sobre o complexo de Édipo. Nela, Lacan destaca a distância que há entre o que a criança é, e o lugar fálico que ela ocupa no desejo materno. "O que acontece na medida em que a imagem do falo para a mãe não é completamente reduzida à criança?"¹⁸, pergunta Lacan. O complexo de Édipo será o recurso teórico para abordar os efeitos simbólicos de tal discordância.¹⁹

Ao giro de cabeça da criança, na teoria do *estádio do espelho*, corresponderá

a ausência materna, na teoria do complexo de Édipo. Lacan verá, na ausência materna, a evidência da discordância entre o que a criança é, e o falo. Se a mãe se ausenta, é porque a criança não é seu único objeto de satisfação, é porque o objeto de seu desejo, o falo, está mais além da criança. A mãe tem uma função essencial para a criança também quando se ausenta.

É a mãe que vai e que vem. É por eu ser um serzinho já tomado pelo simbólico e por haver aprendido a simbolizar, que podem dizer que ela vai e ela vem. Em outras palavras, eu a sinto ou não sinto, o mundo varia com sua chegada e pode desaparecer.²⁰

A mãe que vai e que vem sinaliza que há desejo endereçado a outro lugar que não à criança. A ausência da mãe é reveladora da "dimensão do que a mãe pode desejar de diferente", de que "há nela o desejo de Outra coisa que não o satisfazer meu próprio desejo, que começa a palpitar para a vida"²¹, afirma Lacan.

Para ele, trata-se de um tempo nodal do complexo de Édipo, porque é nele que "a criança desvincula sua dependência efetiva do desejo materno da pura e simples vivência dessa dependência e alguma coisa se institui, sendo subjetivada num nível primário ou primitivo".²² *Se não sou o que minha mãe deseja*, pergunta a criança, *então o que ela deseja?*

A discordância entre *ser o falo*, condição mítica da criança no primeiro tempo, e a apreensão de que o desejo materno está endereçado a outro lugar, mais além dela mesma, tem como efeito a articulação da pergunta que dará ao desejo sua estrutura simbólica e sua definição enquanto desejo do Outro.

{ A pergunta é: qual é o significado? O que quer essa mulher aí? Eu bem que gostaria que fosse a mim que ela quer, mas está muito claro que não é só a mim que ela quer. Há outra coisa que mexe com ela – é o x, o significado.²³

A ausência materna situa o desejo da mãe como um enigma para a criança, x. Aproveitando a fórmula S/s, que define o significante, Lacan escreverá:

17 Idem, p.154.

18 Idem (1956-57), p.71.

19 Efeitos já anunciados na teoria do espelho e no esquema óptico, que situa a distância entre o ideal do eu e o eu ideal.

20 LACAN, J. (1956-57), p.180-181.

21 Idem, p.188.

22 Idem.

23 Idem, p.181.

desejo da mãe

x

Definido por Lacan como o "primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno"²⁴, o desejo da mãe passa a ser o significante cujo significado é esse enigma, x.

Lacan verá, no tratamento significativo da ausência materna, na pergunta sobre o desejo da mãe, a fonte de toda simbolização. O simbólico se instaura pela falta, a partir da pergunta sobre o desejo do Outro.

O jogo do *fort-da*, descrito por Freud em "Mais além do princípio do prazer" (1920), no qual seu neto, antes de completar dois anos de idade – e portanto ainda sem o domínio da linguagem – se entrega à brincadeira de fazer aparecer e desaparecer um carretel amarrado a um cordão, é a evidência mais precoce dessa complexa operação.

O que ele fazia era segurar o carretel pelo cordão e com muita perícia arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que aquele desaparecia por entre as cortinas, ao mesmo tempo que o menino proferia seu expressivo 'o-o-o-ô'. Puxava então o carretel para fora da cama novamente, por meio do cordão, e saudava o seu reaparecimento com um alegre 'da' (aqui). Essa, então, era a brincadeira completa: desaparecimento e retorno.²⁵

Freud interpretará o jogo da criança como uma elaboração simbólica das ausências da mãe, de suas idas e vindas.

Para Lacan, o jogo da criança é a evidência da operação em que a mãe deixa de ser apenas presença e passa a ser também a possibilidade da ausência, corte a partir do qual a engrenagem da estrutura simbólica passa a funcionar. No *Seminário 5* ele afirmará que "essa primeira simbolização está ligada às primeiras articulações que reconhecemos no *fort-da*".²⁶ A dialética presença-ausência e sua articulação ao significante, darão o eixo da estrutura simbólica, segundo Lacan.

O falo, que no primeiro tempo do Édipo era um lugar ocupado miticamente pela criança que supostamente completaria a mãe, passa, no segundo tempo, a ser o significante da falta, aquele que representa o desejo materno, enigma de um desejo que seria o seu, mais além da própria criança. É essa a via pela qual o falo adquire seu estatuto simbólico.

24 Idem, p.180.

25 FREUD, S. (1920), p.26.

26 LACAN, J. (1957-58), p.194.

Inicialmente situado como suporte de uma identificação sustentada miticamente como imaginária, o falo passa a responder pelo enigma do desejo materno, pelo x de seu significado. A mãe passa a ser aquela que vai e vem, sua ausência adquire um estatuto simbólico, aquele no qual "o significado das idas e vindas da mãe é o falo".²⁷

O desejo materno ganha seu estatuto de desejo de outra coisa, e a criança pode interrogar-se sobre seu lugar nesse desejo. Essa interrogação, que é também a interrogação sobre o lugar que o sujeito tem no desejo do Outro – lugar do falo, portanto – orientará, a partir de então, toda posição desejante da neurose.

O falo adquire sua função no campo simbólico, no qual a dimensão da falta tem valor simbólico, apreensível desde o lugar do Outro. O falo passa a ser a marca simbólica da falta, que define o sujeito como castrado, \$, barrado daquilo que o constitui.

No próximo capítulo, veremos como Lacan situa o pai nessa engrenagem, com sua função definida como essencialmente simbólica, ligada ao lugar que ocupa no desejo materno. Veremos que é o lugar do pai, em sua função simbólica, que completa a fórmula com a qual Lacan escreverá o complexo de Édipo, a fórmula da metáfora paterna.

27 Idem, p.181.

capítulo 3

o pai - a função paterna

o Nome-do-Pai

Lacan definirá a função do pai como essencialmente simbólica, situando-a no complexo de Édipo e articulando-a à função da metáfora. Segundo Lacan, "falar do Édipo é introduzir como essencial a função do pai"¹. Para ele, "a função do pai tem seu lugar, um lugar bastante grande, na história da análise. Está no centro da questão do Édipo e é aí que vocês a veem presentificada"².

Entretanto, ele adverte: situar a função simbólica do pai no complexo de Édipo não é tarefa simples.

O pai, *isso não é tão simples*. O pai, sua existência no plano simbólico, no significante pai, com tudo o que este termo comporta de profundamente problemático, como foi que tal função veio ao centro da organização simbólica?³

Em "Totem e tabu" (1913), Freud já situava o pai na origem da lei simbólica. Transforma-a em um mito, o do pai da horda primitiva, no qual é o assassinato do pai que estabelece um pacto entre os irmãos que funda a lei simbólica. No mito freudiano, a lei impõe a interdição do gozo, o do acesso a todas as mulheres, do qual o pai teria sido detentor.

Lacan optará por abordar a função do pai recorrendo à teoria freudiana do complexo de Édipo, dando destaque à articulação entre

1 LACAN, J. (1957-58), p.171.

2 Idem, p.166-167.

3 Idem (1956-57), p.204-205.

sua função simbólica e o complexo de castração. Para Lacan, o complexo de castração é o eixo a partir do qual o Édipo deve ser situado e o pai é a chave para compreender sua função.

Enquanto no mito de "Totem e tabu", a interdição incidia sobre o gozo das mulheres, no Édipo, a interdição que está em jogo é a do gozo da relação incestuosa com a mãe. "O pai intervém em diversos planos. Antes de mais nada, interdita a mãe. Esse é o fundamento, o princípio do complexo de Édipo, é aí que o pai se liga à lei primordial da proibição do incesto".⁴ Nesse sentido, o pai seria "um obstáculo entre o filho e a mãe".⁵

Este é o ponto ressaltado pela grande maioria das leituras acerca da função do pai no complexo de Édipo e é em torno dele que muitas das indagações que envolvem a clínica psicanalítica com crianças parecem girar em falso. Atribui-se ao pai a função de separar a criança da mãe e busca-se, na presença ou ausência do pai no ambiente familiar, e mesmo nas características pessoais de cada pai, respostas para o que se passa com a criança.

Lacan, atento a este equívoco, insistirá na importância da função simbólica do pai, situando o pai não como aquele que efetivamente proíbe, mas como representante da proibição.

É o pai, recordam-nos, que fica encarregado de representar essa proibição. Às vezes tem de manifestá-la de maneira direta, quando a criança se deixa levar por suas expansões, manifestações e pendores, mas é para além disso que ele exerce esse papel. É por toda a sua presença, por seus efeitos no inconsciente, que ele realiza a interdição da mãe. Vocês estão esperando que eu diga: *sob a ameaça de castração*. É verdade, convém dizê-lo, mas isso não é tão simples. É certo que a castração tem nisso um papel manifesto e cada vez mais confirmado. O vínculo da castração com a lei é essencial, mas vejamos como isso se apresenta a nós clinicamente.⁶

Para situar o que se passa na clínica, Lacan buscará esclarecer a diferença entre *ser um pai* e a *função simbólica* do pai.

O que é um pai? Essa pergunta é uma maneira de abordar o problema de significante do pai, mas não nos esqueçamos que também está em jogo que os sujeitos, ao fim de contas, se tornam pais. Formular a questão *o que é um pai?* é algo diverso de ser-se um pai, aceder à posição paterna.⁷

4 Idem (1957-58), p.174.

5 Idem, p.194.

6 Idem, p.174-175.

7 Idem (1956-57), p.209.

Lacan esclarecerá que o que se passa com o pai no ambiente familiar não pode ser confundido com a função simbólica do pai no complexo de Édipo.

O que é um pai? Não digo na família, porque, na família, ele é tudo o que quiser, é uma sombra, um banqueiro, é tudo o que tem de ser, ele o é ou não o é, o que às vezes tem toda a sua importância, mas também pode não ter nenhuma. A questão toda é saber o que ele é no complexo de Édipo.⁸

Para Lacan, não são as características de um pai que definem sua função simbólica, que está ligada à lei e à interdição.

O pai entra em jogo, isso é certo, como portador da lei, como proibidor do objeto que é a mãe. Isso, como sabemos, é fundamental, mas está totalmente fora da questão, tal como esta é efetivamente introduzida para a criança. Sabemos que a função do pai, o Nome-do-Pai, está ligada à proibição do incesto, mas ninguém jamais pensou em colocar no primeiro plano do complexo de castração o fato de o pai promulgar efetivamente a lei da proibição do incesto.⁹

A realidade do ambiente familiar e a função simbólica do pai não devem ser confundidas, portanto.

Existem os pais fracos, os pais submissos, os pais abatidos, os pais castrados pela mulher, enfim, os pais enfermos, os pais cegos, os pais cambaio, tudo o que quiserem. Conviria tentar perceber o que se depreende de tal situação, e encontrar fórmulas mínimas que nos permitissem progredir. Primeiro, a questão de sua presença ou de sua ausência concreta como elemento do meio ambiente. Se nos colocarmos no nível em que se desenrolam essas pesquisas, isto é, no nível da realidade, poderemos dizer que é perfeitamente possível, concebível, exequível, palpável pela experiência, que o pai esteja presente mesmo quando não está, o que já deveria nos incitar a uma certa prudência no manejo do ponto de vista ambientalista no que concerne à função do pai.¹⁰

Quando se confunde a função simbólica do pai com sua presença ou ausência no ambiente familiar, ou com as qualidades ou defeitos de cada pai, o "manejo ambientalista" da clínica, ironicamente denunciado por Lacan, é inevitável.

Para evitar esses desvios e dar maior rigor teórico à função do pai, Lacan insistirá na importância do registro simbólico do complexo de Édipo.

8 Idem (1957-58), p.180.

9 Idem, p.193-194.

10 Idem, p.173.

Com o recurso da linguística, afirmará que o pai é um significante e que sua função no triângulo edipiano pode ser definida a partir da metáfora. Para ele, é "a função de significante que condiciona a paternidade".¹¹

Com essa articulação, esclarecerá que não apenas o pai não faz a lei, que ele é seu representante, mas também que, por representá-la, o pai é um recurso, um recurso significativo.

Essa será a novidade introduzida por Lacan, ao abordar a função do pai com o recurso da metáfora. Embora o pai figure nos mitos neuróticos como um impedimento, como um obstáculo ao desejo incestuoso da criança pela mãe, sua função é, de acordo com Lacan, uma necessidade. A função do pai é necessária para representar o que já tem lugar, e que se impõe desde a relação da criança com a mãe.

Se o complexo de Édipo significa alguma coisa, é que, a partir de um certo momento, a mãe é considerada e vivida em função do pai. O pai merece aqui um P maiúsculo, porque supomos que seja o pai no sentido absoluto do termo. Este é o pai no nível do pai simbólico. É o *nome do pai*, que instaura a existência do pai na complexidade sob a qual ele se apresenta a nós. Esta complexidade, toda a experiência da psicopatologia a decompõe para nós com a chave do complexo de Édipo. A introdução deste elemento simbólico traz uma dimensão nova, radical, à relação da criança com a mãe.¹²

O pai introduz, na relação mãe-criança, uma dimensão nova. Ele é um recurso significativo, que transforma em lei simbólica o que se impõe à criança a partir da relação com a mãe: que o desejo materno não se reduz à criança, que a mãe é considerada e vivida também em função do pai. O pai se torna necessário quando a criança constata esse mais além para onde se dirige o desejo materno.

Observemos esse desejo do Outro, que é o desejo da mãe e que comporta um para-além. Só que para atingir esse para-além é necessária uma mediação, e essa mediação é dada, precisamente, pela posição do pai na ordem simbólica.¹³

O desejo da mãe impõe uma discordância entre o ser da criança e o falo, uma discordância que desloca a criança do lugar que supostamente era o seu. Cabe ao pai, em sua função simbólica, responder por essa discordância.

11 Idem (1958), p.562.

12 Idem (1957-58), p.408.

13 Idem, p.190.

Esse é o passo que permite esclarecer que o pai não interdita, não faz a lei, ele a representa, e a representa na medida em que responde pelo desejo materno, na medida em que dá, ao desejo da mãe, um destino significativo. O pai ordena, em termos da lei simbólica, uma hiância que já tem lugar na relação com a mãe.

Sendo o desejo da mãe o primeiro significante introduzido na simbolização, e sendo o pai o significante que representa este desejo, a função do pai é, por definição, metafórica:

O pai é uma metáfora. Uma metáfora, que vem a ser isso? [...] Uma metáfora, como já lhes expliquei, é um significante que surge no lugar de outro significante. Digo que isso é o pai no complexo de Édipo, ainda que isso venha a aturdir os ouvidos de alguns. Digo exatamente: o pai é um significante que substitui um outro significante. Nisso está o pilar, o pilar essencial, o pilar único da intervenção do pai no complexo de Édipo.¹⁴

A função do significante paterno, do Nome-do-Pai, é substituir o primeiro significante introduzido na simbolização, esse que dá lugar à discordância na relação mãe-criança, o desejo da mãe.

A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno. Segundo a fórmula que um dia lhes expliquei ser a da metáfora, o pai vem no lugar da mãe [...], sendo a mãe como já ligada a alguma coisa que era o x, ou seja, o significado na relação com a mãe.¹⁵

O complexo de Édipo, em sua função simbólica, pode assim ser descrito em uma fórmula, a da metáfora paterna, que localiza, nos efeitos de uma substituição significativa, a função metafórica do pai.

O pai será responsável pelo que Lacan chamará, em "Nota sobre a criança" (1969), vetorização do desejo materno. Na definição de Lacan, o pai "é o vetor de uma encarnação da lei no desejo".¹⁶

Ao distinguir as atitudes de um pai, da função paterna como função simbólica, Lacan oferece um recurso teórico fundamental para reduzir os riscos de um manejo ambientalista da função do pai na clínica.

A clínica opera sobre os efeitos da função simbólica do pai, efeitos que estão no mito individual de cada neurótico, uma construção sempre condicionada pela lógica da estrutura. O que está em jogo na função

14 Idem, p.180.

15 Idem.

16 Idem (1969), p.369.

simbólica do pai no complexo de Édipo não pode ser confundido com a realidade do ambiente familiar, só temos acesso à função na medida em que ela traduz essa realidade em mito.

Nem o complexo de Édipo, nem a castração, devem ser considerados acontecimentos biográficos da criança, portanto. A lei simbólica não depende da intervenção concreta de um pai. Para Lacan, "o pai simbólico não está em parte alguma".¹⁷ O pai representa a castração, sua função é simbólica, ela sustenta uma construção mítica através da qual o neurótico trata, via significante, um limite no gozo.

O mito tem, no conjunto, um caráter de ficção. Mas esta ficção apresenta uma estabilidade que não a torna de modo algum maleável às modificações que lhe podem ser trazidas ou, mais exatamente, que implica que toda modificação implica, por sua vez, por essa razão, uma outra, sugerindo invariavelmente a noção de uma estrutura. Por outro lado, essa ficção mantém uma relação singular com alguma coisa que está sempre implicada por trás dela, e da qual ela porta, realmente, a mensagem formalmente indicada, a saber, a verdade. Aí está uma coisa que não pode ser separada do mito.¹⁸

O gozo já é, segundo a definição de Lacan, "vedado a quem fala como tal"¹⁹, essa é a verdade que o mito encobre. A essa verdade, a de que o gozo está interditado a quem fala, os elementos significantes do Édipo darão uma estrutura de mito.

Por isso, Lacan afirma que "não é a lei em si que barra o acesso do sujeito ao gozo; ela apenas faz, de uma barreira quase natural, um sujeito barrado".²⁰ Ou seja, "a verdadeira função do pai é unir (e não opor) um desejo à lei".²¹

O gozo passará a ter, assim, uma função lógica, que Lacan abordará mais adiante, com o recurso da matemática.²² Ele seria, no Édipo, representado pela lógica do primeiro tempo, um tempo mítico de gozo, só concebível, entretanto, retroativamente, a partir da castração.²³

O destaque dado por Lacan à vertente simbólica do complexo de Édipo permite ver que tanto o incesto, representado pelo desejo

da criança pela mãe, como o gozo, representado pelo pai da horda primitiva de "Totem e tabu", têm um caráter mítico, são construções neuróticas acerca do que teria sido, num tempo supostamente anterior ao estabelecimento da lei.

O mito é o recurso simbólico, estrutural, que dá à verdade sua estrutura de ficção. O complexo de Édipo é, nesse sentido, uma construção mítica que localiza o gozo como anterior à castração e o pai como o responsável por sua interdição.

Se não há incesto, se a criança não é o objeto desejado da mãe, então o desejo materno ganha estatuto de enigma, x , e o Nome-do-Pai passa a ser uma necessidade, a de representar esse enigma do desejo materno.

$$\frac{\text{Nome-do-Pai}}{\text{desejo da mãe}} \cdot \frac{\text{desejo da mãe}}{x}$$

O enigma do desejo materno encontra, no pai, uma resposta significante e é por isso que o pai deve ser considerado um recurso, um recurso simbólico, significante.

A substituição significante metafórica tem, como efeito, um ganho de sentido, porque só há metáfora quando um novo sentido se produz, a metáfora é criação metafórica.

A centelha criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes dos quais um substitui o outro, igualmente atualizados. Ela brota entre dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece presente em sua conexão (metonímica) com o resto da cadeia.²⁴

Na definição de Lacan, "é na substituição do significante pelo significante que se produz um efeito de significação que é de poesia ou de criação ou, em outras palavras, do advento da significação em questão".²⁵

A substituição do significante materno pelo paterno é metafórica porque resulta em um efeito de sentido, para o qual todo desejo passa a ser vetorizado. O efeito de sentido é a significação fálica, ela é o resultado que a criança colhe da estrutura do Édipo.

17 Idem (1956-57), p.215.

18 Idem, p.258.

19 Idem (1960), p.836.

20 Idem, p.836.

21 Idem, p.839.

22 Ver o seminário de 1966-67 sobre a lógica do fantasma, onde Lacan escreve a fórmula: $S < > a$.

23 Sobre o complexo de Édipo, a função simbólica do pai e sua relação com o gozo, ver FARIA, (2006) e (2014).

24 LACAN, J. (1957), p.510.

25 Idem, p.519.

Trata-se de que a criança assuma o falo como significante, e de uma maneira que faça dele instrumento da ordem simbólica das trocas, na medida em que ele preside à constituição das linhagens. Trata-se, em suma, de que ela se confronte com esta ordem que fará da função do pai o pivô do drama.²⁶

Com a fórmula da metáfora paterna, Lacan escreverá a estrutura que define a função simbólica do complexo de Édipo. Do lado direito, está a significação fálica como o efeito da metáfora:²⁷

$$\frac{\text{Nome-do-Pai}}{\text{desejo da mãe}} \cdot \frac{\text{desejo da mãe}}{\text{Significado do sujeito}} \rightarrow \text{Nome-do-Pai} \frac{(A)}{\text{falo}}$$

Sendo a função do pai definida como metafórica e a lei do pai situada em seu valor significante, como um recurso da neurose, tudo o que se articula em torno de sua função simbólica deve ser situado na perspectiva do mito.

Os desvios de um manejo ambientalista da clínica que confunde as atitudes de um pai com sua função simbólica tendem a se dissipar com a leitura que Lacan propõe para a função simbólica, metafórica, do pai no complexo de Édipo.

Essa é uma dimensão que, é claro, é igualmente da ordem do significante, e que se encarna em pessoas que sustentam essa autoridade. Que essas pessoas faltem, vez por outra, ou que haja carência paterna, por exemplo, no sentido de o pai ser imbecil demais, não é o essencial. O essencial é que o sujeito, seja por que lado for, tenha adquirido a dimensão do Nome-do-Pai. Acontece efetivamente, é claro, e vocês podem levantar nas biografias, que o pai, muitas vezes, está presente para lavar a louça da cozinha com o avental da mulher. Isso não basta, em absoluto, para determinar uma esquizofrenia.²⁸

Lacan esclarece, assim, que as atitudes positivas ou negativas de um pai, com as quais os psicanalistas se deparam na clínica com crianças, não determinam a função simbólica do pai.

O complexo de Édipo passa a ser um recurso teórico para mostrar que a os efeitos da análise incidem sobre o mito de cada sujeito, sobre a interpretação que condiciona a neurose de cada um.

Mas então, qual seria o sentido da escuta dos pais na clínica com crianças? Se não são as atitudes de um pai, nem sua posição concreta no ambiente familiar que determinam a posição subjetiva da criança, a análise não deveria orientar-se apenas para a escuta da criança, para a interpretação no trabalho com a criança? Na medida em que Lacan esclarece que o psicanalista não opera sobre as funções, mas com aquilo que é seu efeito, qual a razão para escutar pai e mãe?

Ainda que as atitudes de um pai não possam ser diretamente relacionados ao sintoma da criança, não se pode ignorar que as características de cada pai, assim como os dados biográficos que envolvem a figura paterna também contribuem para a composição da neurose dos filhos.

Como, então, escutar os pais? Qual seria o objetivo da escuta dos pais nas análises das crianças, uma vez esclarecidas as diferenças entre as funções e a presença concreta dos pais no ambiente familiar da criança?

26 Idem (1956-57), p.204.

27 Idem (1958a), p.563.

28 Idem (1957-58), p.162.

capítulo 4

pais e criança: sujeitos, lugares ou funções?

As referências às figuras paterna e materna são frequentes na teoria psicanalítica, quando o assunto é a clínica com crianças. Qual o papel e a função da mãe e do pai na constituição psíquica da criança, qual o lugar reservado a cada um deles no triângulo familiar em que a criança está inserida, são perguntas que muito constantemente se apresentam aos psicanalistas que se ocupam das crianças e de seus pais.

Na busca de respostas que orientem o trabalho clínico, as teorias sobre a constituição do sujeito, embora tragam esclarecimentos importantes, oferecem também o risco de confundir conceitos com personagens concretamente presentes no ambiente familiar da criança. Quando isso acontece, a tendência é de um manejo desviante da clínica, ironicamente chamado por Lacan de ambientalista.

No *Seminário 5*, Lacan adverte dos riscos desse manejo, e observa:

Nem todos os analistas incorrem nessa mania, graças a Deus. Muitos analistas a quem vocês levarem informações biográficas interessantes, do tipo *mas os pais não se entendiam, havia um desentendimento conjugal, isso explica tudo*, lhes responderão, inclusive aqueles com quem nem sempre estamos de acordo: - *E daí? Isso não prova absolutamente nada. Não devemos ater-nos a nenhuma espécie de efeito particular* - e terão razão.¹

1 LACAN, J. (1957-58), p.172.

Talvez tenha sido justamente para evitar os riscos de uma prática que se deixa desviar pelas informações biográficas, que as referências aos pais irão praticamente desaparecer do ensino de Lacan, que optará por dar destaque às funções – materna, paterna, fálica – e aos lugares – o Outro, o Nome-do-Pai, o falo – a elas articulados.

Se nos capítulos anteriores nossa preocupação foi definir, a partir da teoria lacaniana, tais funções e lugares, o problema clínico do manejo da presença dos pais nas análises de crianças exige, entretanto, retornar aos personagens concretos e aos dados biográficos. Um retorno que requer atenção especial aos riscos do manejo ambientalista denunciado por Lacan.

O desafio que a presença concreta dos pais impõe à escuta é evitar as distorções que resultam no manejo desviante da clínica, no qual se confundem conceitos com personagens do ambiente familiar. É, portanto, na clínica psicanalítica com crianças que se torna mais evidente o desafio e a dificuldade de utilizar os conceitos como norteadores de uma prática que possa ser considerada rigorosamente psicanalítica.

A mãe

A primeira distorção a evitar está na tendência de sobrepor o lugar do Outro à personagem materna, como se a patologia da criança estivesse diretamente ligada ao exercício da maternidade e em especial àquilo que a mãe diz à criança.

Quando o próprio Lacan dá destaque à função da mãe, insistindo na importância do acolhimento da criança no nascimento e mostrando seu papel de interpretar as necessidades e atribuir sentido ao choro da criança, quando ele mesmo nomeia de Outro primordial o lugar ocupado pela mãe no exercício de sua função, suporte primeiro do campo da linguagem para a criança, o caminho para esse tipo de equívoco está aberto.²

Entretanto, uma leitura rigorosa da teoria esclarece que a mãe não é o grande Outro, assim como o campo do Outro não pode ser reduzido à figura materna. A mãe serve de suporte para esse lugar que Lacan chamou de Outro, porque o que está em jogo é a linguagem, o sentido. O exercício interpretativo do choro da criança confere à mãe esse

2 Nem mesmo Laplanche, que em *O inconsciente e o Id* (p.100-101) faz uma leitura crítica da teoria lacaniana, escapou deste equívoco. Ao afirmar que "o inconsciente da criança não é diretamente o discurso do outro, nem mesmo o desejo do outro" e que "a criança não interioriza o desejo da mãe", ele critica uma concepção do Outro que é tão criticável quanto equivocada, por sugerir que Lacan teria afirmado que a mãe, presente na vida da criança, seria o Outro.

lugar porque, nesse exercício, a mãe opera, primordialmente, enquanto suporte do campo do sentido.³

Por isso, a rigor, o Outro é definido por Lacan como o campo da linguagem, tesouro dos significantes do qual o ser humano depende para constituir-se enquanto sujeito. Nomear a mãe de Outro primordial, como fez o próprio Lacan, é apenas lembrar seu papel primordial no exercício da função de nomeação e de atribuição de sentido.

Mas é importante lembrar que ainda que dependa dos significantes que encontra no Outro, uma criança não pode ser reduzida ao que a mãe, mesmo nessa função de suporte da linguagem, diz sobre ela.

Conforme vimos nos capítulos anteriores, embora a criança dependa do significante para encontrar seu lugar no mundo, do significante que está no campo do Outro e que funciona, portanto, como um espelho no início da vida, o sujeito não se reduz à imagem do espelho, ele se constitui também por uma hiância, uma abertura nessa imagem, abertura que Lacan chamou desejo do Outro.

Ainda que a posição subjetiva da criança dependa de sua alienação ao campo do Outro, a alienação comporta uma hiância e, portanto, a criança não se reduz ao efeito da alienação, não está condenada a ele.

Foi a esse ponto que Lacan deu ênfase em sua teoria da alienação⁴, insistindo que a alienação ao significante, ao campo da linguagem, ao sentido, ao Outro, só pode ser definida em uma operação lógica que inclui a separação. O sujeito é, ao mesmo tempo, efeito da alienação ao significante e do resto que resulta dessa operação, resto que dá lugar à hiância onde se sustenta a lógica da separação, da qual depende o estatuto do Outro como desejante.⁵

Por isso, ao escutar os pais, o psicanalista tem diante de si o desafio de, ao mesmo tempo, considerar a importância do que dizem à criança, mas lembrando também que reduzir ou identificar a criança a esses ditos é esquecer que, mesmo alienada ao significantes que recolhe deste

3 Lembremos que este papel pode ser exercido tanto pela mãe como por qualquer um que se ocupe da criança nos primeiros momentos de vida. As novas configurações familiares exigem atenção especial ao fato de que as culturas mudam, as famílias mudam e que essas mudanças, não resultam, necessariamente, em prejuízo da função de suporte necessária à constituição psíquica da criança. Sobre as novas configurações familiares, ver a apresentação da terceira edição de *Constituição do sujeito e estrutura familiar*. In: FARRA, 2014.

4 Esse problema começa a ser abordado por Lacan no *Seminário 9* (1961-62), sobre a identificação, e terá destaque na teoria sobre a alienação do *Seminário 11* (1964, p.199).

5 LACAN, J. (1964), p.198-199.

espelho que é o Outro ao qual os pais dão suporte, a criança responde desde sua própria posição.

Conforme a definição de Lacan em "Nota sobre a criança"⁶, o sintoma da criança responde ao sintoma do casal parental – uma resposta que é a da criança, portanto. Ainda que seu lugar esteja em íntima relação com a oferta significativa oriunda do discurso de cada um dos pais, a criança não entra aí passivamente.

A dificuldade que se impõe ao psicanalista que se propõe a escutar os pais é separar os discursos, localizando seus efeitos sobre cada um dos envolvidos no triângulo pai-mãe-criança que compõe a estrutura familiar, e lembrando sempre que a função de suporte dos pais não significa um assujeitamento da criança a seu discurso. É o que dá, ao psicanalista da criança, condição para discriminar o lugar do Outro na perspectiva de sua função psíquica, situável na posição da própria criança, ou seja, na resposta que ela puder formular ao que recolhe desse campo. É somente nessa perspectiva que uma escuta rigorosamente psicanalítica pode ser sustentada.

A criança

O falo é o conceito que permite evitar os desvios de uma outra tendência que pode comprometer a escuta do psicanalista, a de confundir a criança que aparece no discurso dos pais com a criança que é efetivamente trazida para tratamento.

É para situar o lugar da criança no desejo dos pais que Lacan recorrerá ao falo, lembrando a teoria freudiana sobre a função fálica de um filho, especialmente na saída do complexo de Édipo da mulher. Sobre um filho são projetados ideais, que fazem com que ele represente, para cada um dos pais, a ilusão de plenitude e satisfação narcísica que lhe dá o lugar que Freud chamou de "sua majestade o bebê". As expectativas que os pais depositam em um filho têm, portanto, íntima relação com o lugar fálico que ele ocupa no desejo de cada um dos pais, esse é o lugar estrutural no qual a criança é capturada.

Do lado dos pais, esse esclarecimento sobre o lugar fálico do filho permite compreender que há expectativas que, embora incidam sobre a criança, remetem à posição de cada um deles. Essa compreensão permite recolocar o discurso de cada um dos pais sobre o filho na perspectiva

de sua própria posição e de seus próprios ideais, evitando o risco de responder, na transferência, à demanda de reconduzir a criança às expectativas que se tenham sobre ela, ao ideal fálico que nela depositam cada um dos pais. Quando o psicanalista é capturado por essa demanda dos pais, em que se transforma a análise da criança?

O sintoma da criança representa sempre uma quebra, uma ruptura nas expectativas que os pais depositam sobre ela. Seu sintoma é a evidência de um descompasso nos ideais que ela representa para os pais. Desde a perspectiva dos pais, é o lugar fálico da criança que está em questão.

Consequentemente, a demanda de tratamento envolverá, em alguma medida, a expectativa de resgate deste ideal. Trata-se de um aspecto inconsciente da demanda que, inevitavelmente, produzirá efeitos sobre a transferência dos pais com o psicanalista.

Quando a escuta dos pais se restringe à queixa sobre o sintoma da criança, é inevitável que o psicanalista seja capturado em um pacto de restituição do lugar fálico da criança idealizada, que evidentemente pesará sobre a transferência. Nesses casos, não é incomum que a expectativa de restituição fálica se transforme em pressão dos pais para que o sintoma da criança desapareça.

Oferecer uma escuta aos pais que considere esse aspecto inconsciente de sua demanda pode ser uma saída, na medida em que essa escuta produza efeitos sobre estes ideais e, consequentemente, sobre a transferência da qual o psicanalista depende para analisar uma criança.

Um trabalho atento aos aspectos inconscientes da demanda inicial dos pais pode, assim, ser de grande auxílio para o trabalho com a criança, porque permite discriminar o lugar idealizado reservado a ela, da função fálica que orienta o desejo de cada um dos personagens envolvidos no triângulo pai-mãe-criança.

Uma escuta rigorosamente psicanalítica seria aquela que, atenta ao lugar no qual a criança é capturada no desejo dos pais, não desconsidera que a posição desejante de cada um dos envolvidos nessa captura está orientada pela função fálica.

O pai

Finalmente, do lado da função paterna, Lacan define o Nome-do-Pai como o significante que ordena as relações do sujeito com o desejo e a lei, com o falo e a castração. É a partir desse significante que o desejo se articula e a neurose se estrutura.

⁶ Idem (1969).

Lacan insistirá na distinção entre a função paterna – recurso simbólico do sujeito, lugar do significante Nome-do-Pai na articulação da lei – e a presença ou ausência concreta do pai no ambiente familiar. Sendo a função simbólica do pai um recurso do sujeito, nenhuma atitude positiva ou negativa do pai, nem mesmo sua presença ou sua ausência no ambiente familiar, serão determinantes da função.

Distinguir o pai do ambiente familiar, da função simbólica do pai, que dá ao Nome-do-Pai seu lugar na articulação da lei que orienta o desejo, é essencial para evitar as distorções de um manejo da clínica que busca, nas atitudes de um pai, as causas do sofrimento da criança.

É somente quando o psicanalista não confunde conceitos com personagens concretos, quando não identifica a função significativa do pai, seu lugar como representante da lei simbólica, com o pai presente ou ausente no ambiente familiar, que fica claro que a função simbólica do pai deve ser situada na perspectiva do sujeito, e não do ambiente familiar no qual ele está inserido. Quando se trata da função simbólica do pai, se o sujeito em questão é a criança, é para a posição subjetiva da criança que a escuta do psicanalista deve estar orientada. O mesmo vale, evidentemente, para a escuta e o manejo da presença dos pais, uma vez que tanto o pai como a mãe também estão, assim como a criança, em uma certa posição em relação à lei simbólica.

A advertência de Lacan é que não se confunda o que é um pai na família com sua posição simbólica. Isso não implica, evidentemente, descartar os efeitos das atitudes de um pai na relação com seu filho. Não é indiferente que o pai seja amável ou agressivo, que esteja presente ou não na vida de uma criança. Entretanto, ao esclarecer que a função do pai é essencialmente simbólica, o que Lacan esclarece também é que mesmo quando os dados biográficos que envolvem o pai sejam relevantes, o manejo clínico do tratamento não pode desviar-se para a crença de uma relação direta entre as atitudes de um pai e sua função simbólica. Para Lacan, atribuir uma relação causa-consequência entre a patologia observada na criança e as atitudes concretas de um pai ou de uma mãe será sempre um equívoco que produz desvios no manejo do tratamento.

Creio que o erro de orientação é este: confundem-se duas coisas que estão relacionadas, mas que não se confundem – o pai como normativo e o pai como normal. O pai pode, é claro, ser muito desnormalizador, na medida em que ele mesmo

não seja normal, mas isso é rejeitar a questão para o nível da estrutura – neurótica, psicótica – do pai. Logo, a normalidade do pai é uma questão, e a de sua posição normal na família é outra.⁷

Que o pai seja normal ou não – quaisquer que sejam os critérios para avaliá-lo – não decide de sua função. A advertência de Lacan é, portanto, de grande auxílio para manter uma escuta rigorosamente psicanalítica da criança, aquela que considera a posição da criança, sua própria resposta às atitudes do pai ou da mãe e que, portanto, não envereda pelo equívoco de atribuir as causas de seu sintoma à realidade do ambiente familiar no qual ela está inserida.

Passaremos agora à **Parte II**, advertidos da necessidade de reduzir os riscos do manejo ambientalista da clínica, sempre presentes nos tratamentos com crianças. O caminho traçado até aqui para reduzir tais riscos foi o de situar a estrutura que se configura em torno do triângulo pai-mãe-criança sob três perspectivas:

1. a do SUJEITO: considerando que uma escuta que se pretenda rigorosamente psicanalítica não poderia excluir de seu campo o sujeito do inconsciente, e que essa escuta não é somente da criança, mas também do pai e da mãe, que demandam tratamento para um filho a partir de sua própria posição subjetiva, que é determinante tanto do enlace de cada um deles com a criança e seu sintoma, como de sua transferência com o psicanalista e, conseqüentemente, com o próprio tratamento.

2. a das FUNÇÕES: lembrando que, embora as teorias sobre a constituição do sujeito coloquem em destaque as funções do pai e da mãe, considerar a estrutura implica levar em conta que a *função paterna*, assim como a *materna* e a *filial*, não operam apenas para a criança, estando também a mãe e o pai submetidos a elas.

3. a dos LUGARES: admitindo que para-além das funções, mas guardando relação com estas, está o lugar do *Outro* e sua relação com a linguagem enquanto determinante do sujeito, bem como o lugar do *Nome-do-Pai* enquanto suporte simbólico da lei e da castração e, finalmente, o lugar do *falo* enquanto o que dá a estrutura do desejo.

Na **Parte II** discutiremos a utilidade desse recurso para o manejo da clínica psicanalítica com crianças e, principalmente, para a abordagem do lugar dos pais nesta clínica a partir das *entrevistas preliminares* dos tratamentos das crianças.

⁷ Idem (1957-58), p.174.

PARTE 2



a clínica psicanalítica com crianças

Na clínica psicanalítica com crianças, a demanda de tratamento é, inicialmente, dos pais. São os pais que telefonam, que marcam um horário, que trazem a queixa e pedem ajuda ao psicanalista. Mais que um traço particular dos tratamentos de crianças, a presença dos pais define uma especificidade, porque exige intervenção.

Mesmo que o psicanalista opte pela exclusão dos pais, reduzindo as entrevistas ao mínimo possível e mantendo-os fora do *setting* analítico, essa opção de manejo marca uma posição que terá efeitos sobre a transferência dos pais com o psicanalista e, conseqüentemente, sobre a própria análise da criança.

Freud, em suas recomendações técnicas, chamava de *experimento preliminar* o período no qual o psicanalista avalia a presença de condições necessárias ao início de uma análise. Lacan optará por chamá-las *entrevistas preliminares*, ressaltando que as condições para que a análise aconteça dependem também do manejo do psicanalista e de suas intervenções. Segundo Lacan, "não há entrada possível em análise sem as entrevistas preliminares".¹

Quando se trata da criança, a preocupação com o estabelecimento das condições necessárias para a análise, a serem estabelecidas nas entrevistas iniciais, é ainda mais preciosa, porque funciona como advertência para o próprio psicanalista: seria a queixa dos pais condição suficiente para tomar uma criança em análise?

Freud levantará essa questão no caso da jovem homossexual, ao afirmar que uma análise não pode ser feita por encomenda. Segundo

1 LACAN, J. (1971-72).

ele, "não é indiferente que alguém venha à psicanálise por sua própria vontade ou seja levado a ela; quando é ele próprio que deseja mudar, ou apenas os seus parentes, que o amam".²

O fato de a criança ser trazida impõe, portanto, não só a necessidade de uma reflexão sobre o lugar dos pais nas análises de seus filhos, como também sobre o manejo de sua presença.

Para evitar os riscos do tratamento por encomenda, de uma análise orientada apenas pelas demandas e expectativas dos pais, as *entrevistas preliminares* devem ser consideradas, também nos casos das crianças, um período de avaliação das condições necessárias ao início de uma análise, com uma reflexão que inclua o manejo do psicanalista tanto com os pais como com a própria criança.

Nossa reflexão sobre a clínica tomará, portanto, as *entrevistas preliminares* como ponto de partida para discutir os efeitos dessa estrutura que envolve o triângulo pai-mãe-criança e propor um manejo da presença dos pais que leve em conta a especificidade dos laços que compõem esse triângulo.

Do lado da criança, será fundamental situar as consequências, para sua análise, de considerar sua posição de *sujeito* e sua relação com os *lugares* e as *funções* para os quais os pais servem de suporte. Do lado dos pais, mostraremos a importância de levar em conta os mesmos elementos dessa estrutura desde o ângulo de suas próprias demandas e do lugar que o filho ocupa em relação a elas.

2 FREUD, S. (1920), p.189.

capítulo 5

o sintoma e as entrevistas preliminares - sintoma da criança e sintoma na criança

O sintoma da criança é a via de entrada para seu tratamento, com uma particularidade que o caracteriza. Aquele que procura o psicanalista, aquele que sofre com o sintoma, aquele que se queixa, não é a criança. Há uma impossibilidade, própria à condição da criança, de que ela nos procure por si mesma. Ainda que a criança tenha sintomas, sintomas que lhe causem sofrimento, ela só virá ao encontro com o psicanalista se seu sintoma fizer questão para seus pais, produzindo uma demanda de tratamento que é, inicialmente, deles.

O caso da mãe de Julia é um alerta para as dificuldades que se impõem à escuta do psicanalista devido a essa particularidade. Ao se queixar dos sintomas da filha, a mãe diz: *não quero que ela sofra como eu sofro*. De quem é o sofrimento que traz Julia para a análise? É da criança?

Embora sejam os pais que trazem a criança, nem sempre o psicanalista está atento ao fato de que a queixa dos pais envolve um sofrimento que é deles. A queixa da mãe de Julia é a expressão clara da origem do sofrimento que envolve o tratamento da criança. É a mãe que sofre, e vê nos sintomas da filha a possibilidade de que, como ela, Júlia venha a sofrer também. É o que faz com que o sintoma de Julia mobilize, na mãe, uma questão. Outras tantas crianças "tímidas" nunca serão levadas

para uma análise, simplesmente porque, para seus pais, a timidez dos filhos não é fonte de angústia e, portanto, não constitui um sintoma.

A primeira condição de toda análise de criança é, portanto, uma demanda inicial dos pais que se articula pela via de um sintoma, um sintoma que os pais localizam *na* criança.

No caso da mãe de Julia, a demanda por tratamento inclui a timidez que a mãe observa na filha, mas é desde sua própria angústia que este sintoma é nomeado: *não quero que ela sofra como eu sofro*.

O caso de Pedro é igualmente revelador da presença desse viés da subjetividade dos pais na queixa do sintoma *na* criança. A mãe se preocupa com o comportamento agressivo do menino, que havia entrado recentemente na escola. Pedro agride não só as outras crianças, mas também a professora. Em casa, é muito agitado e na ocasião em que a mãe procura tratamento, quebrava objetos da casa em frequentes crises de fúria.

Na primeira entrevista de Pedro, a surpresa é inevitável. O menino, então com 6 anos de idade, *não fala*. Comunica-se através de urros e grunhidos e não articula sequer uma palavra compreensível. Entretanto, a dificuldade de comunicação de Pedro não é uma queixa de sua mãe. Que Pedro não fale, não é, para ela, um sintoma. "Não falar" não traz angústia, não é motivo de queixa, não produz demanda de tratamento. No discurso da mãe, este não é um sintoma.

O sintoma nomeado pelos pais é, como alertam os casos de Júlia e Pedro, sempre um recorte marcado pela subjetividade dos pais. Os riscos de supor que se compreende o que se passa com a criança a partir do que dizem os pais está sempre presente na clínica com crianças e exige que se mantenha em suspenso, até que se possa ver a criança, a atribuição daquele sintoma nomeado pelos pais à própria criança.

Ao sintoma *da* criança, só é possível ter acesso no contato com a própria criança. O sintoma de um sujeito é aquele através do qual aquele sujeito em particular se representa, e ele só pode ser tomado enquanto tal em seu próprio discurso. Se a criança é o sujeito em questão, sua via de entrada para a análise será também a de seu sintoma, mas daquele que ela mesma puder nomear como tal.

Essa é mais uma particularidade do trabalho com a criança. O fato de a criança ser trazida exige uma escuta atenta à possibilidade de nomeação, pela própria criança, de seu sintoma. Um sintoma que nem

sempre coincide com aquele de que os pais se queixam.

É o caso de Gabriel que nomeia seu sintoma como *um branco*. Branco que tem nos momentos de fazer provas, desde que o professor supôs que ele estivesse colando. Segundo ele, isso o deixa muito nervoso na escola, ainda que *saiba tudo*. Acha que precisa de ajuda para descobrir por que ele tem *esse branco*.

A mãe se queixa da imaturidade de Gabriel. O filho é, segundo ela, muito infantil por ser um filho temporão do casal, imaturo em comparação com crianças de sua idade. Ou seja: um sintoma nomeado pela mãe e outro, pela criança.

A estrutura que se impõe ao psicanalista de crianças exige, portanto, situar o sintoma de duas maneiras diferentes:

1. como sintoma *na* criança, sintoma enquanto atribuído à criança por aquele que demanda inicialmente seu tratamento;
2. e como sintoma *da* criança, sintoma nomeado como tal pelo sujeito em questão, que é a própria criança.

Tal distinção, longe de sugerir que os pais não sabem do sofrimento dos filhos ou desconhecem o que se passa com a criança, é antes um alerta para os riscos de tomar a criança em tratamento supondo que o que se passa com ela pode ser apreendido e tratado apenas a partir do discurso dos pais.

Não se trata de confrontar os discursos, o da criança com o dos pais, a fim de buscar a verdade capaz de orientar o tratamento para um objetivo comum mas, ao contrário, de lembrar que, tanto no que diz a mãe, como no que diz o pai, e também no que diz a própria criança, há verdade.

Há verdade do sujeito, daquele que fala, e a questão que se impõe aos tratamentos das crianças é de como escutar essa verdade que está no sintoma de que se queixam os pais, o sintoma *na* criança, mas também no sintoma de que se queixa a própria criança. Como decifrar essa verdade presente no sintoma *da* criança, e como escutá-la quando se trata de uma queixa alienada na criança, de um sintoma *na* criança?

Para que a análise da criança não corra o risco de tornar-se uma análise por encomenda, é importante que o psicanalista não se perca no esforço vão de fazê-la falar daquilo que incomoda os pais, perdendo a dimensão do sujeito na análise.

Se a criança é o sujeito em questão, cabe esperar a nomeação

para uma análise, simplesmente porque, para seus pais, a timidez dos filhos não é fonte de angústia e, portanto, não constitui um sintoma.

A primeira condição de toda análise de criança é, portanto, uma demanda inicial dos pais que se articula pela via de um sintoma, um sintoma que os pais localizam *na* criança.

No caso da mãe de Júlia, a demanda por tratamento inclui a timidez que a mãe observa na filha, mas é desde sua própria angústia que este sintoma é nomeado: *não quero que ela sofra como eu sofro*.

O caso de Pedro é igualmente revelador da presença desse viés da subjetividade dos pais na queixa do sintoma *na* criança. A mãe se preocupa com o comportamento agressivo do menino, que havia entrado recentemente na escola. Pedro agride não só as outras crianças, mas também a professora. Em casa, é muito agitado e na ocasião em que a mãe procura tratamento, quebra objetos da casa em frequentes crises de fúria.

Na primeira entrevista de Pedro, a surpresa é inevitável. O menino, então com 6 anos de idade, *não fala*. Comunica-se através de urros e grunhidos e não articula sequer uma palavra compreensível. Entretanto, a dificuldade de comunicação de Pedro não é uma queixa de sua mãe. Que Pedro não fale, não é, para ela, um sintoma. "Não falar" não traz angústia, não é motivo de queixa, não produz demanda de tratamento. No discurso da mãe, este não é um sintoma.

O sintoma nomeado pelos pais é, como alertam os casos de Júlia e Pedro, sempre um recorte marcado pela subjetividade dos pais. Os riscos de supor que se compreende o que se passa com a criança a partir do que dizem os pais está sempre presente na clínica com crianças e exige que se mantenha em suspenso, até que se possa ver a criança, a atribuição daquele sintoma nomeado pelos pais à própria criança.

Ao sintoma *da* criança, só é possível ter acesso no contato com a própria criança. O sintoma de um sujeito é aquele através do qual aquele sujeito em particular se representa, e ele só pode ser tomado enquanto tal em seu próprio discurso. Se a criança é o sujeito em questão, sua via de entrada para a análise será também a de seu sintoma, mas daquele que ela mesma puder nomear como tal.

Essa é mais uma particularidade do trabalho com a criança. O fato de a criança ser trazida exige uma escuta atenta à possibilidade de nomeação, pela própria criança, de seu sintoma. Um sintoma que nem

sempre coincide com aquele de que os pais se queixam.

É o caso de Gabriel que nomeia seu sintoma como *um branco*. Branco que tem nos momentos de fazer provas, desde que o professor supôs que ele estivesse colando. Segundo ele, isso o deixa muito nervoso na escola, ainda que *saiba tudo*. Acha que precisa de ajuda para descobrir por que ele tem *esse branco*.

A mãe se queixa da imaturidade de Gabriel. O filho é, segundo ela, muito infantil por ser um filho temporão do casal, imaturo em comparação com crianças de sua idade. Ou seja: um sintoma nomeado pela mãe e outro, pela criança.

A estrutura que se impõe ao psicanalista de crianças exige, portanto, situar o sintoma de duas maneiras diferentes:

1. como sintoma *na* criança, sintoma enquanto atribuído à criança por aquele que demanda inicialmente seu tratamento;
2. e como sintoma *da* criança, sintoma nomeado como tal pelo sujeito em questão, que é a própria criança.

Tal distinção, longe de sugerir que os pais não sabem do sofrimento dos filhos ou desconhecem o que se passa com a criança, é antes um alerta para os riscos de tomar a criança em tratamento supondo que o que se passa com ela pode ser apreendido e tratado apenas a partir do discurso dos pais.

Não se trata de confrontar os discursos, o da criança com o dos pais, a fim de buscar a verdade capaz de orientar o tratamento para um objetivo comum mas, ao contrário, de lembrar que, tanto no que diz a mãe, como no que diz o pai, e também no que diz a própria criança, há verdade.

Há verdade do sujeito, daquele que fala, e a questão que se impõe aos tratamentos das crianças é de como escutar essa verdade que está no sintoma de que se queixam os pais, o sintoma *na* criança, mas também no sintoma de que se queixa a própria criança. Como decifrar essa verdade presente no sintoma *da* criança, e como escutá-la quando se trata de uma queixa alienada na criança, de um sintoma *na* criança?

Para que a análise da criança não corra o risco de tornar-se uma análise por encomenda, é importante que o psicanalista não se perca no esforço vão de fazê-la falar daquilo que incomoda os pais, perdendo a dimensão do sujeito na análise.

Se a criança é o sujeito em questão, cabe esperar a nomeação

do sintoma pela criança, o endereçamento de sua própria queixa ao psicanalista.

É o que faz Alice, com um *não sei* que a princípio é sua resposta para a pergunta sobre o que a traz para tratamento, mas que se transforma, ao longo das primeiras entrevistas, em uma posição de recusa de saber em que seu aniversário ganhará um lugar importante. O que aparentava ser uma ausência de queixa revela-se, retroativamente, a marca de sua posição subjetiva, na qual o *não saber* inclui não só seu nascimento, mas uma série que remete também à escola, aos amigos e, principalmente, à família e à história de sua adoção. O *não sei* inicial adquire consistência de sintoma a partir das *entrevistas preliminares* com a criança.

Quando Freud lembra que não se faz análise por encomenda, ele adverte da necessidade de que a queixa seja também da criança, que ela possa nomear seu próprio sintoma, através do qual poderá articular sua demanda de análise. Quando a presença da criança é apenas resposta ao desejo dos pais, não havendo uma demanda própria, não há análise possível da criança.

O giro a partir do qual a demanda de tratamento de Marcelo foi formulada é ainda mais surpreendente. Contrariado, o menino se queixava, desde a primeira entrevista, que não era seu desejo estar ali. O esforço de mantê-lo em tratamento foi, por algum tempo, da mãe. As entrevistas eram difíceis e tensas, marcadas pela raiva e pela recusa, até que surge uma primeira e curiosa demanda: *Você vai dizer para minha mãe que estou bem*. Surpresa com o pedido, devolve: *Ah, é? Mas porque eu, porque você mesmo não diz isso a ela?* O caminho para a análise se abre com a queixa finalmente formulada pela criança: *Porque ela não acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Nem você, nem meus pais, nem meus amigos da escola*.

O sintoma nem sempre está presente desde o início do tratamento e pode exigir um trabalho prévio à análise, mesmo no caso dos adultos. Localizar o sintoma que sustente uma queixa que seja da própria criança, o sintoma *da* criança, distinguindo-o do sintoma *na* criança, é o trabalho das *entrevistas preliminares*. Ainda que os pais nomeiem um sintoma *na* criança, e que seja por essa nomeação que a criança chegue ao tratamento, tomar a criança a partir do sintoma nomeado pelos pais é esquecer que o sintoma com o qual o psicanalista trabalha é o sintoma *da* criança.

Fernando, depois de passar as primeiras entrevistas jogando entediadas partidas de damas sem o menor interesse ou entusiasmo, traz uma pergunta, em tom de desafio: *De que vai adiantar, para eu resolver meus problemas, ficar jogando damas aqui com você?* Sua pergunta produzirá um giro na posição que assumirá inicialmente, abrindo a possibilidade de reconduzi-lo ao caminho de sua análise: *Ah, então você tem problemas a resolver?*

A diferença entre o sintoma *da* criança e o sintoma *na* criança pode ser um recurso para que o psicanalista se mantenha atento à necessidade de recolocar e reconduzir cada discurso àquele que o enuncia. Essa distinção explícita o lugar do sintoma como ponto de enredamento da estrutura que se configura nas *entrevistas preliminares*, com a complexidade e os problemas que ela impõe à escuta do psicanalista.

Estar advertido de tal complexidade é essencial para que o sintoma de que falam os pais seja escutado de maneira que a decisão sobre a análise da criança possa permanecer em suspenso até que ela mesma possa articular seu sintoma, sua própria demanda.

São portanto duas as condições preliminares que se apresentam para a análise de uma criança: a presença do sintoma *da* criança, ou seja, que a criança encontre o fio de sua própria demanda e de sua própria queixa na análise; e a presença do sintoma *na* criança, que o sintoma da criança produza nos pais um sofrimento que se traduza em demanda de tratamento, sem a qual a criança não virá.

É essa montagem, a de uma estrutura que se configura nas *entrevistas preliminares* em torno do sintoma – sintoma *da* criança e sintoma *na* criança – que está em jogo quando os pais pedem um tratamento para um filho. Entendemos que se o psicanalista estiver atento para as particularidades dessa estrutura, ele estará em boa posição para o manejo clínico dos casos.

capítulo 6

o lugar dos pais na estrutura

Conforme vimos até aqui, nas análises de crianças está em jogo, desde o início, uma estrutura que inclui pai, mãe e criança, que podem ser situados sob três perspectivas diferentes: como *sujeitos*, como *funções* e como *lugares*. Essa estrutura se apresenta, ao psicanalista, nas *entrevistas preliminares* dos tratamentos de crianças pela presença de um sintoma, com seus desdobramentos enquanto sintoma *na e da* criança.

Como essa concepção pode auxiliar a situar o manejo clínico da presença dos pais nas análises de seus filhos?

Vimos que a literatura psicanalítica oferece uma série de possibilidades de manejo da presença dos pais na clínica com crianças, sem um padrão que possa orientar a intervenção do psicanalista. As referências teóricas, oriundas das teorias sobre a constituição do sujeito, acrescentam a essa variedade de possibilidades de intervenção, ainda mais dificuldades. A maior delas é o risco de um manejo ambientalista da clínica, no qual as atitudes do pai ou da mãe são avaliadas a partir de um ideal imposto pela teoria.

A distinção entre o sintoma *na* criança e o sintoma *da* criança é recurso valioso, em primeiro lugar, para manter uma escuta da criança orientada pela concepção de que o sintoma é *da* criança e remete a sua própria posição de *sujeito*. Mas é também um recurso que não deixa esquecer que, justamente devido à presença da demanda dos pais nas *entrevistas preliminares* nas análises de crianças, há uma dificuldade maior para o psicanalista de manter essa escuta orientada para a demanda da

criança, para o sintoma *da* criança. É um recurso, portanto, para que o psicanalista possa dar o devido lugar à queixa dos pais como uma queixa que remete à posição e ao sofrimento de cada um deles, reduzindo os riscos da análise por encomenda, da análise da criança que se sustenta unicamente na demanda dos pais.

A solução que muitos psicanalistas encontram para o risco de um desvio no qual as demandas dos pais dificultam a escuta da criança, foi mantê-los fora do tratamento, o que seria uma forma de preservar uma escuta rigorosamente orientada para a concepção de sujeito que norteia a clínica. Quanto mais o psicanalista considera a subjetividade da criança – de Melanie Klein aos Lefort – maior a tendência a excluir os pais, como forma de eliminar um referente que poderia obstruir a escuta da criança, conforme lembram Hartmann e Tkach.

De fato, essa parece ser a melhor maneira de preservar o tratamento da criança, porque torna mais clara a distinção entre o *lugar* que a criança ocupa na estrutura e sua posição enquanto *sujeito*. É uma estratégia que permite separar as determinações inconscientes do sintoma da criança, que são circunscritas ao trabalho com a criança, das atitudes, demandas e queixas dos pais. Elimina-se o risco de confundir a criança em análise com aquela da qual falam os pais.

Entretanto, se a estrutura que está em jogo nas *entrevistas preliminares* das análises de crianças inclui os pais, excluí-los é uma intervenção. Quais seriam os efeitos dessa intervenção, que desconsidera as queixas e demandas dos pais? O que ocorre do lado dos pais, quando estes são excluídos do *setting* das análises de seus filhos?

O efeito da intervenção que exclui os pais é, muito frequentemente, que aquilo que não é escutado, da posição de cada um, irrompa nas análises dos filhos, causando interferências que os psicanalistas tendem a analisar como resistências. Os pais deixam de pagar, faltam, abandonam o tratamento. A possibilidade de ruptura na análise da criança, sempre colocada no horizonte quando a transferência dos pais não encontra, no manejo do analista, um ponto estável de sustentação, é um fantasma que costuma assombrar os psicanalistas que fazem essa opção. O que se encontra alienado no sintoma *na* criança transborda na transferência dos pais.

Uma saída possível para esse transbordamento, é encaminhar os pais ou um deles para uma análise pessoal. É uma intervenção que mantém o

analista em seu lugar de escuta da criança e, ao mesmo tempo, considera que as interferências remetem à posição subjetiva dos pais, que deve ser analisada, tanto quanto a da criança. É a proposta de Anna Freud, que sustentava que sem a análise dos pais não seria possível analisar os filhos.

No entanto, não é incomum que o encaminhamento dos pais ou de um deles a um outro psicanalista seja mal-sucedido. A insistência de alguns pais em endereçar demandas ao analista do filho – foi o que ocorreu com a mãe de Júlia – é um alerta para a necessidade do manejo do sintoma *na* criança, pelo analista da criança. Quando Mannoni afirma que obrigar os pais a uma análise pessoal é inútil, uma vez que o sintoma destes se apresenta alienado no sintoma da criança, ela está atenta para esse aspecto, que está na base do tão comum fracasso desses encaminhamentos. A diferença entre encaminhar para uma análise e oferecer uma escuta é radical e produz efeitos muito diferentes na transferência dos pais.

Mesmo que os pais procurem outro psicanalista, o lugar que o filho tem na estrutura não impedirá que eles sigam endereçando certas demandas ao analista da criança. Conforme vimos anteriormente, se o filho, no lugar do falo, é lugar privilegiado de alienação das questões dos pais, é inevitável que a transferência com o analista da criança sofra o impacto dessa alienação.

A análise pessoal dos pais não elimina sua necessidade de falar sobre o sintoma *na* criança, essa é a crítica de Melanie Klein a Anna Freud, que lembra que mesmo que, conscientemente, os pais queiram ajudar, suas resistências dizem respeito a seu próprio inconsciente.

Assim, quando o psicanalista opta por excluir os pais, trata-se de uma intervenção que não é sem efeito, porque exclui também a possibilidade de escuta daquilo que está alienado no sintoma *na* criança e que aparece na tendência dos pais a escapar do tema, ou fazer confidências de suas próprias vidas ao psicanalista, conforme afirma Aberastury.

Mas como considerar tais “confidências” no contexto da demanda pela análise da criança?

Se, na estrutura que se configura nas *entrevistas preliminares*, a criança ocupa, em relação aos pais, um *lugar* que se define como fálico, lugar privilegiado de alienação de seu desejo, a queixa sempre remeterá à posição subjetiva de cada um dos pais, àquilo que se encontra alienado no sintoma *na* criança.

Os pais de Lorena estavam, há alguns meses, com dificuldades para fazer a menina dormir em seu próprio quarto. Já haviam tentado várias estratégias, de historinhas na cama a luminárias divertidas, de broncas a atitudes mais carinhosas e acolhedoras, até que, seguindo uma orientação do pediatra, tomaram uma atitude que os levou a concluir que precisavam da ajuda de um psicanalista: *Ele sugeriu que a colocássemos na cama, apagássemos a luz e disséssemos que era hora de dormir, que ela ia dormir na cama dela, e que fechássemos a porta. Que ela iria chorar, mas que logo dormiria. Fizemos isso. Era ela chorando do lado de dentro e nós dois chorando do lado de fora.*

O que fazer a partir de um relato como esse? Tomar a criança em análise, a partir da queixa dos pais? Escutar o sintoma *na* criança como se remetesse, de fato, à criança e seu próprio sintoma?

Se a escuta considera a posição de *sujeito* daquele que se queixa, trata-se daquilo que se encontra alienado nesse sintoma, nessa queixa. *Sabe o que eu pensei, contando essa cena para você? Que o que fizemos naquele dia me fez sentir como se eu fosse a mãe biológica de minha filha, que a abandonou no orfanato quando ela nasceu.*

Quando o psicanalista se ocupa daquilo que os pais têm a dizer sobre o sintoma *na* criança, o que se encontra aí alienado pode ser esclarecido, desatando o nó que une sintomaticamente pai, mãe e criança. Na semana seguinte a essa sessão, Lorena já tinha voltado a dormir em seu próprio quarto.

Quando os pais não são escutados, o psicanalista não apenas perde a oportunidade de desatar esse nó, como também corre o risco de selar inadvertidamente um pacto de restituição narcísica do filho idealizado pelos pais, assumindo o risco de que o trabalho com a criança se transforme em resposta para uma demanda de cura que é dos pais. Não é incomum, nesses casos, que os pais se queixem que a análise *não está funcionando*, o que é revelador não só da aposta implicitamente sustentada na transferência dos pais, como também do ideal de cura que a mantém.

Ainda que se trate de uma escuta rigorosamente psicanalítica, porque considera a posição de *sujeito* de cada um dos pais, não se trata, entretanto, como sugeria Anna Freud, da análise dos pais. Trata-se de operar sobre essa estrutura na qual pai-mãe-criança estão inseridos, o que envolve uma escuta dos pais voltada para o sintoma *na* criança.

Ainda que a escuta dos pais remeta à subjetividade de cada um

deles, trata-se de recolocar o que só pôde aparecer alienado no sintoma *na* criança. Trata-se de situar como cada um dos pais lida com o sintoma do qual se queixam, evitando a tendência a esquecer que é de seu próprio sofrimento e desde sua própria posição que eles falam.

Se os pais servem de suporte às *funções* e aos *lugares* de que depende a constituição psíquica da criança, pode-se esperar, dessa escuta dos pais, efeitos sobre toda a estrutura. Efeitos não previsíveis, evidentemente, mas que podem ser notados tanto do lado da criança, como do lado dos pais.

Do lado dos pais, desata-se o nó que une pais e criança através do sintoma *na* criança e a questão, antes alienada, retorna para o sujeito que a traz. Do lado da criança, os efeitos são os de uma análise que pode seguir seu curso, uma vez que a escuta do psicanalista fica livre das interferências oriundas do discurso dos pais e, conseqüentemente, da iminência constante de interrupção provocada pelas insistentes demandas dirigidas ao analista, que passam a ser abordadas em uma outra via, na qual eles se percebem implicados.

conclusões

Desde o caso Hans, a pergunta sobre o lugar dos pais na clínica psicanalítica das crianças permanece aberta. Freud delegou ao pai a função de analista do filho, convencido, na ocasião, de que a confiança do filho no pai seria facilitadora da análise de Hans. Mas os efeitos problemáticos das análises de crianças conduzidas por seus próprios pais mostraram a necessidade de buscar novas estratégias de manejo clínico.

Mais de 20 anos depois da publicação do caso Hans, Freud ainda lembrava as dificuldades que a presença dos pais impõem à clínica com crianças:

A eficácia terapêutica da psicanálise permanece tolhida por numerosos fatores de peso e dificilmente abordáveis. Quanto ao caso das crianças, em que se pode contar com os maiores êxitos, as dificuldades são externas, influenciadas pelo relacionamento com os pais, embora tais dificuldades, afinal, necessariamente façam parte da condição da criança.¹

Se tais dificuldades fazem parte da condição da criança, seu manejo clínico é inevitável, a presença dos pais sempre exigirá uma intervenção.

Mas a escolha por uma ou outra forma de intervenção não é casual. Ela está ligada a uma certa maneira de compreender os conceitos que norteiam a clínica, o que é uma criança e sua posição no triângulo pai-mãe-criança.

Se, para Melanie Klein, tanto quanto para os Lefort, a criança é um sujeito analisável como o adulto; se, de acordo com Mannoni as causas do sintoma da criança devem ser buscadas no discurso dos pais;

1. FREUD, S. (1933), p.188.

e se Anna Freud entende que a análise dos pais é imprescindível para a análise da criança, é porque há, entre estes autores, concepções bastante diferentes, tanto do que seja uma criança, como do seu lugar no triângulo pai-mãe-criança do qual depende sua constituição psíquica.

Seria a criança um analisando por inteiro, como sugerem tanto Melanie Klein como os Lefort? Ou sua condição de dependência dos pais exige considerar especificidades também em sua condição de sujeito analisável, como propõe Mannoni? O que significa a afirmação de Lacan de que o sintoma da criança é resposta ao sintomático do casal parental? A condição de dependência da criança é também uma condição de assujeitamento a ser tratada com os pais, ou a criança formula sua própria resposta a essa condição, como sugerem Hartmann e Tkach? Porque Dolto e Aberastury consideram contraindicado que o mesmo psicanalista escute os pais e a criança?

O lugar que o psicanalista reserva aos pais no tratamento dos filhos, mais que um problema técnico, é revelador das concepções teóricas que fundamentam a clínica com crianças. Independentemente da escolha de manejo clínico, ela estará sempre na mais íntima dependência de tais concepções.

Em 1953, Lacan já afirmava que a teoria e a técnica psicanalítica "não formam senão uma única e mesma coisa"² e no seminário de 1964, ao abordar o tema da transferência, voltará a lembrar a relação íntima entre a prática e os conceitos que a norteiam, afirmando que os conceitos dirigem o modo de tratar os pacientes, tanto como o modo de tratá-los determina a compreensão dos conceitos.³ Segundo Lacan, "a teoria e a prática, sempre se disse, não podem se dissociar uma da outra e, a partir do momento em que se concebe a experiência num certo sentido, é inevitável que se a conduza igualmente nesse sentido".⁴

Partimos, portanto, de um problema clínico, do fato de que são os pais, e não a criança, que procuram o psicanalista, circunscrevendo-o às *entrevistas preliminares* nos tratamentos de crianças.

Em seguida, nossa preocupação foi retomar a teoria lacaniana a respeito do sujeito, de como ele se constitui e do papel do triângulo pai-mãe-criança nessa constituição, a fim de esclarecer em que bases teóricas pode sustentar-se uma proposta de manejo clínico da presença dos pais.

2 LACAN, J. (1953), p.11-12.

3 Idem (1964), p.120.

4 Idem (1953), p.11-12.

A partir das teorias sobre a constituição do sujeito em Lacan, situamos o enlace entre pai, mãe e criança como definido a partir *funções e lugares*, considerando também que se trata de *sujeitos*.

Esta foi a base que permitiu delimitar o trabalho das *entrevistas preliminares* dos atendimentos de crianças como circunscrito à estrutura que se articula em torno de um sintoma, que propusemos situar em duas perspectivas distintas, enquanto sintoma *na* criança e como sintoma *da* criança.

Tais coordenadas permitiram propor um manejo clínico da presença dos pais nas análises dos filhos compatível com a perspectiva rigorosamente psicanalítica de sujeito e de inconsciente com a qual o psicanalista opera.

É uma posição ética que sustenta que o emaranhado que envolve a criança e seu sintoma, na estrutura que se configura nas *entrevistas preliminares* dos tratamentos das crianças, exige um manejo que esteja orientado pela concepção de sujeito e de inconsciente que sustentam toda escuta que se pretenda psicanalítica.

Lembrando Freud:

As resistências internas contra as quais lutamos, nos casos dos adultos, são muitas vezes substituídas, nas crianças, pelas dificuldades externas. Se os pais são aqueles que propriamente se constituem em veículos de resistência, o objetivo da análise — e a análise como tal — muitas vezes corre perigo. Daí se deduz que muitas vezes é necessária determinada dose de influência analítica junto aos pais.⁵

Entendemos que desatar este emaranhado, permitindo a cada um dos envolvidos na trama reconhecer sua posição, é a base essencial para vencer as resistências ao tratamento da criança, especialmente aquelas relativas à transferência dos próprios pais com o psicanalista, da qual todo tratamento da criança depende.

5 FREUD, S. (1933-[32]), p.181.

bibliografia

- ABERASTURY, Arminda. *A percepção da morte na criança e outros escritos*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.
- _____. *Psicanálise da criança*. 8. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
- BLEICHMAR, Silvia. Do discurso parental à especificidade sintomática na psicanálise de crianças. In: *O lugar dos pais na psicanálise das crianças*. São Paulo: Escuta, 1994.
- BRAUER, Jussara Falek (Org.). *A criança no discurso do Outro*. São Paulo: Iluminuras, 1994.
- CHECCINATO, Durval. *Psicanálise de pais: criança, sintoma dos pais*. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2007.
- CHINOY, Ely. *Sociedade: uma introdução à sociologia*. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1971.
- DOLTO, Françoise. *Seminário de psicanálises de crianças*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1990.
- FARIA, Michele Roman. Análise de quem? In: Brauer, J. F. A. (Org.). *A criança no discurso do Outro*. São Paulo: Iluminuras, 1994.
- _____. Das entrevistas preliminares aos tratamentos com crianças às entrevistas preliminares com a criança. *Acheronta Revista de Psicoanálisis y Cultura*, n. 20, dez. 2004.
- _____. Constituição do sujeito e complexo de Édipo. *Stylus Revista de Psicanálise*. Associação Fóruns do Campo Lacaniano, n. 12, abr. 2006, p.81-94.
- _____. O Édipo e as novas configurações familiares. Apresentação da

- terceira edição. In: *Constituição do sujeito e estrutura familiar: o complexo de Édipo, de Freud a Lacan*. 3ª ed. São Paulo: Cabral Editora, 2014.
- FLESLER, Alba. *A psicanálise de crianças e o lugar dos pais*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2012.
- FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Traduzido do alemão e do inglês sob a direção geral de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
- _____. (1909). Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. v. X.
- _____. (1913[1912-13]). Totem e tabu. v. XIII.
- _____. (1913). Sobre o início do tratamento. v. XII.
- _____. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. v. XIV.
- _____. (1918[1914]). História de uma neurose infantil. v. XVII.
- _____. (1920). A psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher. v. XVIII.
- _____. (1920). Mais além do princípio do prazer. v. XVIII.
- _____. (1923). O ego e o id. v. XIX.
- _____. (1924). A dissolução do complexo de Édipo. v. XIX.
- _____. (1925). Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. v. XIX.
- _____. (1926). A questão da análise leiga. v. XX.
- _____. (1931). Sexualidade feminina. v. XXI.
- _____. (1933[1932]). Novas conferências introdutórias sobre a psicanálise. v. XXII.
- HARTMANN, Alicia; TKACH, Carlos. Los padres, bajo transferencia en la clínica de niños neuróticos. In: *Niños en psicoanálisis*. Buenos Aires: Manantial, 1989.
- KLEIN, Melanie. *Contribuições à psicanálise*. São Paulo: Mestre Jou, 1982.
- LACAN, Jacques (1949). O estágio do espelho como formador da função do eu. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1953a). O simbólico, o imaginário e o real. In: *Nomes-do-Pai*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
- _____. (1953b). Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

- _____. (1953-54). *Seminário 1: os escritos técnicos de Freud*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
- _____. (1954-55). *Seminário 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
- _____. (1956-57). *Seminário 4: a relação de objeto*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995.
- _____. (1957). A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1957-58). *Seminário 5: as formações do inconsciente*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
- _____. (1958a). A significação do falo. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1958b). De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1960a). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1960b). Observação sobre o relatório de Daniel Lagache. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1961-62). *Seminário 9: a identificação*. Inédito.
- _____. (1962-63). *Seminário 10: a angústia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
- _____. (1963). Introdução aos Nomes-do-Pai. In: *Nomes-do-Pai*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
- _____. (1964). *Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- _____. (1969). Nota sobre a criança. In: *Outros escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
- LEFORT, Rosine. Unidade da psicanálise. In: MILLER, Judith (Org.). *A criança no discurso analítico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.
- _____. Um passo a mais entre a criança e o adulto: a estrutura do corpo. In: *A criança no discurso analítico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.
- _____. Introdução à jornada de estudos do CEREDA. In: *A criança no*

discurso analítico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.

MANNONI, Maud. *A criança retardada e a mãe*. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

_____. *A criança, sua doença e os outros*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.

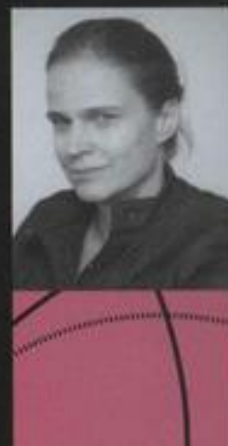
RIO, Angela Batista do (Org.). *Do pai e da mãe*. Salvador: Ágalma, 1993. Coleção Psicanálise da Criança, v. 1, n. 4/5.

ROSENBERG, Ana Maria Sigal de (Org.). *O lugar dos pais na psicanálise de crianças*. São Paulo: Escuta, 1994.

WINNICOTT, Donald Woods. *Da pediatria à psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.

_____. *Os bebês e suas mães*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

Michele Roman Faria é psicanalista, formada em psicologia pela Universidade de São Paulo – USP, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica pela mesma universidade. É Pós-doutora pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, onde desenvolveu pesquisa sobre o imaginário, o simbólico e o real na obra de Jacques Lacan. Atua há mais de 20 anos como psicanalista em consultório particular e como docente em cursos de pós-graduação. É autora de *Constituição do sujeito e estrutura familiar: o complexo de Édipo, de Freud a Lacan* (Cabral, 2023, 7ª ed.) e *Real, simbólico e imaginário no ensino de Jacques Lacan* (Toro, 2019) e organizadora da coleção *O psicanalista: na instituição, na clínica, no laço social, na arte* (Toro, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023). Coordenou a tradução do *Índice de referências dos seminários de Jacques Lacan*, de Henry Krutzen (Toro, 2022).



Na clínica psicanalítica com crianças, a demanda de tratamento é, inicialmente, dos pais. São eles que telefonam, que marcam um horário, que se queixam, que trazem a criança.

Neste livro, Michele Roman Faria mostra que, mais que um traço particular dos tratamentos de crianças, a presença dos pais impõe uma especificidade, porque exige intervenção.

Freud, em suas recomendações técnicas, chamava de *experimento preliminar* o período no qual o psicanalista avalia as condições necessárias ao início de uma análise. Lacan preferiu chamá-las de *entrevistas preliminares*, ressaltando a importância do manejo do psicanalista para obter tais condições.

É das *entrevistas preliminares* aos tratamentos de crianças que a autora se ocupa neste livro, procurando mostrar que, para obter as condições necessárias para o tratamento psicanalítico de uma criança, o psicanalista deve estar advertido da necessidade de um manejo que inclui tanto os pais como a criança.

ISBN 978-85-92779-00-9

